

Cancerplan och processplaner för norra sjukvårdsregionen 2022-2024

Uppföljning av kvalitetsregister från norra
sjukvårdsregionen - täckningsgrader och
målindikatorer

april 2025



Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus
SE-901 85 UMEÅ

Innehållsförteckning

1	Inledning	1
2	Täckningsgrader för anmälan	3
2.1	Täckningsgrader per tidsperiod	4
2.2	Täckningsgrader per region	5
2.3	Täckningsgrader per sjukhus	6
3	Målindikatorer	7
3.1	Bröstcancer	8
3.2	Bukspottkörtelcancer	15
3.3	Hudcancer	17
3.4	Cancer i lever och gallvägar	21
3.5	Lung- och lungsäckscancer	22
3.6	Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)	30
3.7	Matstrupe/Magsäckscancer	32
3.8	Palliativa registret	34
3.9	Prostatacancer	40
3.10	Sköldkörtelcancer	49
3.11	Tjocktarmscancer	52
3.12	Ändtarmscancer	58

1 Inledning

Sedan etableringen av regionala cancercentrum (RCC) har RCC haft i uppdrag att ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet. I grunduppdraget ingick att varje RCC skulle ta fram en cancerplan för sin sjukvårdsregion, baserad på den nationella cancerstrategin. Dessa planer har sedan reviderats med jämna intervall. Utöver den nationella cancerstrategin har nu även EU tagit fram en gemensam cancerstrategi för unionen. Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet fastställde i juni 2022 cancerplanen för norra sjukvårdsregionen för perioden 2022–2024 ([strategisk utvecklingsplan för cancervården i norra sjukvårdsregionen](#)). Denna uppföljningsrapport är den sista för cancerplanen för 2022–2024. En ny sjukvårdsregional cancerplan för 2025–2028 fastställdes i december 2024. Den nya cancerplanen följs upp första gången under 2026.

De sjukvårdsregionala cancerplanerna har sedan starten varit omfattande och omfattat ett stort antal diagnosspecifika mål. Cancerplanen för norra sjukvårdsregionen 2022–2024 är kortare, för att alla ska kunna ta del av och förstå den. En bred förankring och förståelse för cancerplanen är viktigt för att gemensamt utveckla av cancervården i norra sjukvårdsregionen och för att möta de stora utmaningar som finns.

Som komplement till den sjukvårdsregionala cancerplanen finns detaljerade planer för de olika vårdprocesserna inom cancervården. Planerna är publicerade på RCC Norrs webbplats. I processplanerna finns konkreta målnivåer definierade. De diagnosspecifika målen avser i högutsträckning ledtider, samt specifika åtgärder inom utredning eller behandling. Vården är enligt lag skyldig att anmäla alla nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd till cancerregistret. För de allra flesta cancerformer finns diagnosspecifika kvalitetsregister. Dessa innehåller patientbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat. Kvalitetsregistren visar hur väl vårdprogrammen följs och utvärderar behandlingsresultaten. De gör det också möjligt att följa upp enskilda sjukhus eller klinikersarbete. I många av de detaljerade vårdprocessplanerna finns flera definierade mål som kan följas genom kvalitetsregistren. I den

sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022–2024 är ett mål att kvalitetsregisterdata ska användas för styrning av verksamheten. Regionerna ska nå ”nationella målnivåer” i nationella vårdprogram och kvalitetsregister.

För att data från kvalitetsregistren ska vara tillförlitliga krävs en hög täckningsgrad. Det är ett mått på hur många av de patienter som finns registrerade i cancerregistret som även finns registrerade i kvalitetsregistret för den aktuella tumörformen. Kvalitetsregister omfattar flera rapporteringssteg, från anmälan av en ny patient till uppföljningar, som skiljer sig åt mellan diagnoser. RCC Norr redovisar täckningsgrader ur cancervårdens kvalitetsregister som gäller anmälningsformulären, på sjukvårdsregion-, region- (landstings-) och sjukhusnivå. I denna rapport redovisas huvudsakligen statistik för 2023 och 2024.

Täckningsgraderna för 2024 redovisas uppdelat per halvår. I den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2022–2024 är ett mål att täckningsgrader och inrapporteringshastighet i kvalitetsregistren inom cancerområdet ska förbättras.

För täckningsgrader som gäller andra formulär än anmälningsformulären hänvisas till [interaktiva rapporter](#). För inrapportörer av registerdata till INCA finns även aktuella täckningsgrader per diagnos redovisade, dels på sjukhusnivå och dels för andra formulär än anmälningsformuläret där täckningsgrader går att beräkna.

I denna rapport redovisas även statistik för diagnosspecifika målnivåer. Data presenteras dels för sjukvårdsregionen, regionerna, per sjukhus samt i jämförelse med riket för åren 2023–2024 och dels redovisas utvecklingen i norra sjukvårdsregionen under de senaste fem åren.

Rapporteringen omfattar de vårdprocesser där RCC Norrs processledare och deras sjukvårdsregionala arbetsgrupper har identifierat målnivåer som kan följas i kvalitetsregistren. Målkategorierna har beräknats av nationella statistiker för aktuell diagnos efter beställning från RCC Norrs processledare. Utformandet av rapporten och be-

räkningar av täckningsgrader för norra sjukvårdsregionen har gjorts av RCC Norrs statistiker.

Data till denna uppföljningsrapport hämtades från registren den 4 april 2025.

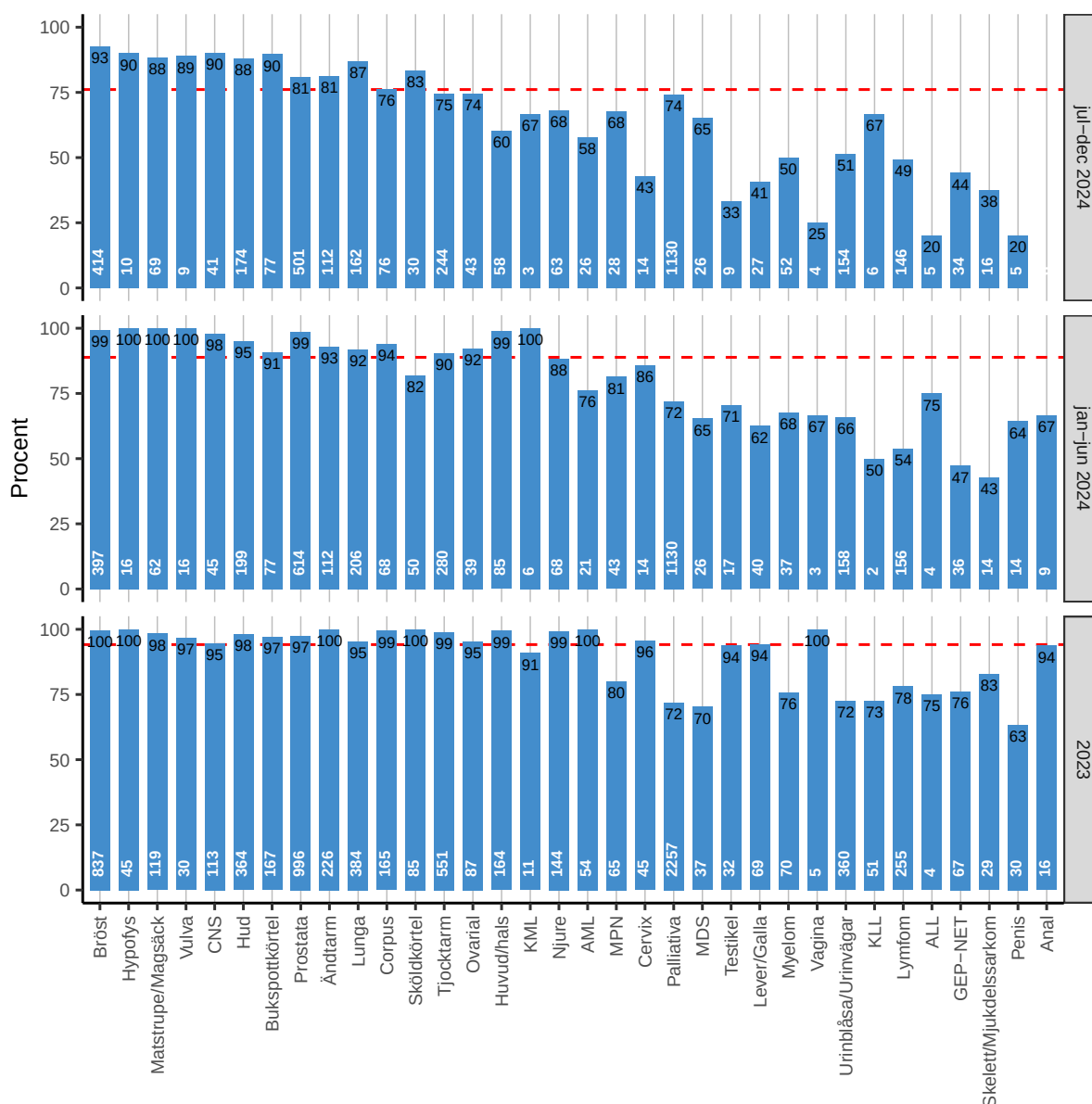
2 Täckningsgrader för anmälan

Tumörer som uppfyller inklusionskriterierna för ett specifikt kvalitetsregister ska registreras både i kvalitetsregistret och cancerregistret. Täckningsgraden för kvalitetsregistrets anmälningsformulär motsvarar den andel av tumörerna i cancerregistret som också registrerats i kvalitetsregistret. Anmälningsformuläret är i regel det första formulär som registreras i kvalitetsregistret för en ny tumör och innehåller bland annat information om primärtumörens lokalisation. Täckningsgraden är ett viktigt kvalitetsmått för den statistik som redovisas med hjälp av data från ett kvalitetsregister.

Vid redovisning av täckningsgrader för anmälningsformuläret baseras sjukhus på uppgifter från cancerregistret. Om en tumörpost i cancerregistret saknar anmälningsformulär från kvalitetsregistret representeras sjukhus av den enhet som initialt tagit diagnostiserande prov.

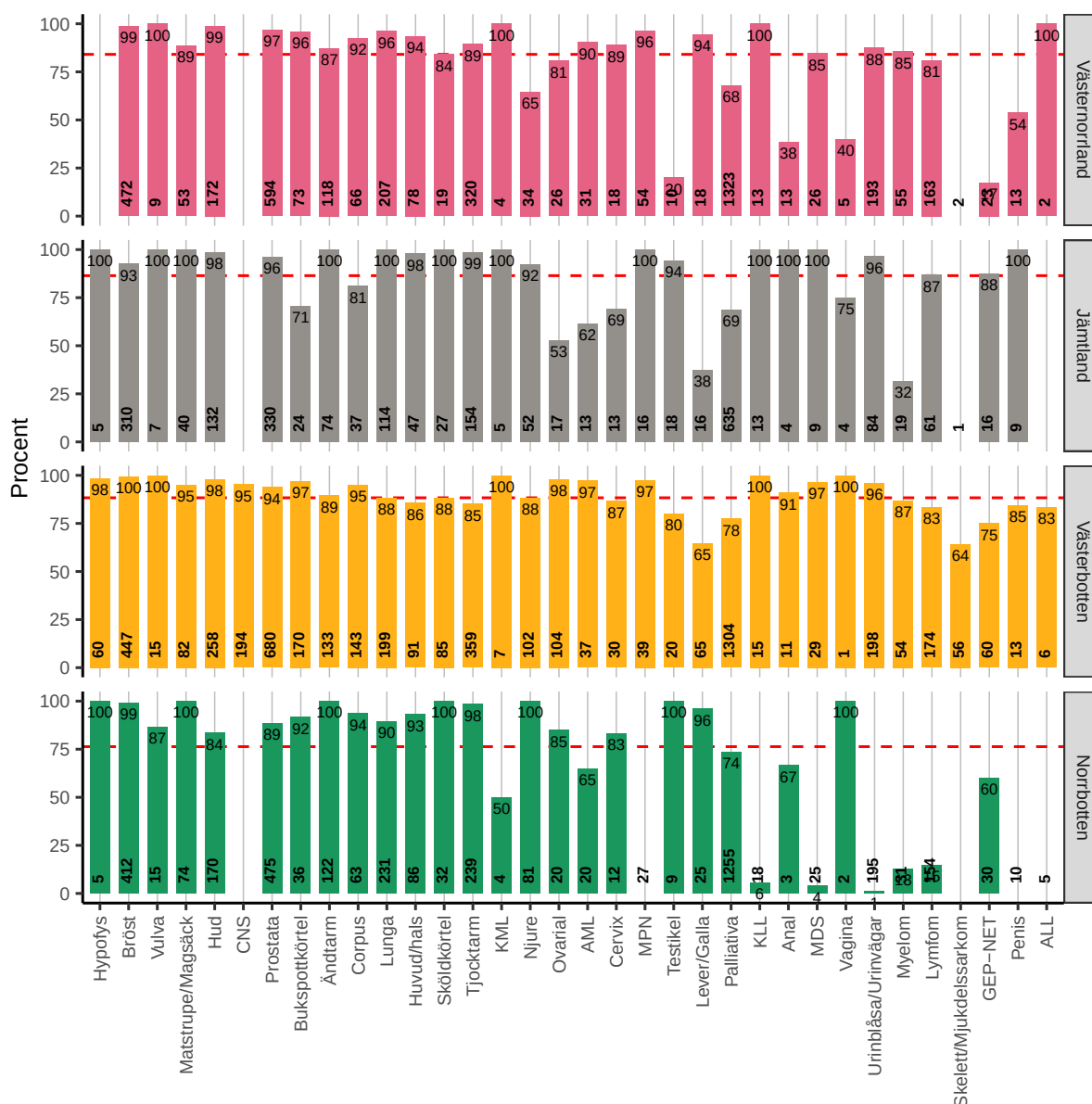
Täckningsgrad för palliativa registret görs genom att relatera antal registrerade i palliativa registret med grundsjukdom cancer med förväntat antal baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksregister

2.1 Täckningsgrader per tidsperiod



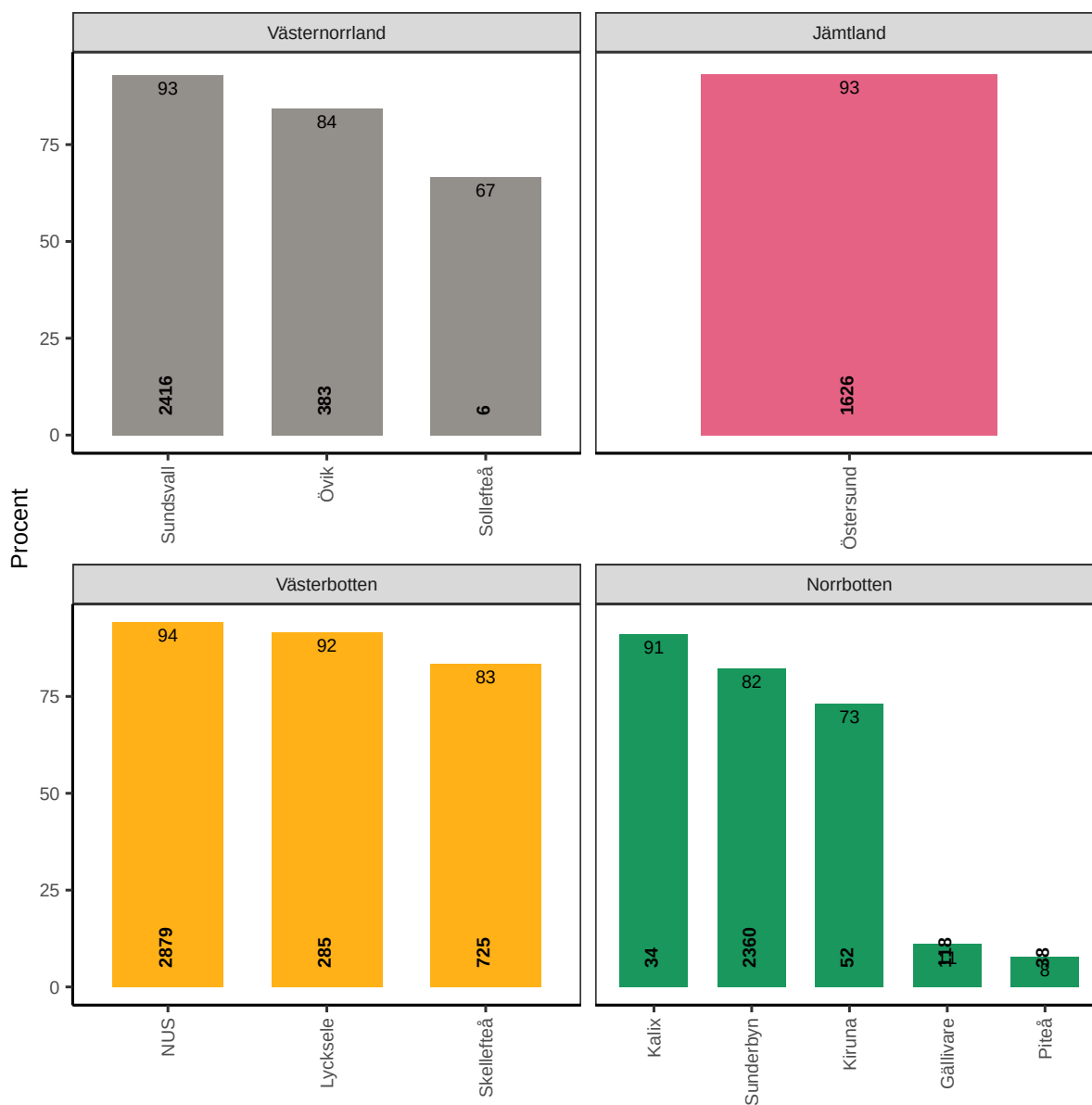
Figur 1. Täckningsgrader för anmälningsformulären per **diagnos och tidsperiod för norra sjukvårdsregionen**. Siffrorna i vit text längst ner på staplarna representerar hur många diagnoser som skall vara registrerade i kvalitetsregistret för att uppnå full täckningsgrad (antal i cancerregistret). Röda streckade linjen visar genomsnittlig täckningsgrad per tidsperiod (Palliativa registret exkluderade). Genomsnittlig täckningsgrad för 2023 var 94.1%, januari-juni 2024 88.9% och juli-december 2024 76.1%. Staplarna är sorterade från högsta till lägsta täckningsgrad för hela tidsperioden 2023-2024

2.2 Täckningsgrader per region



Figur 2. Täckningsgrader för anmälningsformulären 2023-2024 per **diagnos och region**. Siffrorna nere på staplarna representerar hur många diagnoser som skall vara registrerade i kvalitetsregistret för att uppnå full täckningsgrad (antal i cancerregistret). Röda streckade linjen visar genomsnittlig täckningsgrad per län (Palliativa registret exkluderade). Genomsnittlig täckningsgrad för Västernorrland var 84.1%, Jämtland 86.4%, Västerbotten 88.3% och Norrbotten 76.3%. Staplarna är sorterade från bästa till sämsta täckningsgrad baserat på totalt för hela norra regionen. Att summan av antal diagnoser i figur 1 kan vara något fler än i figur 2 beror på att patienter anmälda från utanför norra regionen inte finns med i figur 2.

2.3 Täckningsgrader per sjukhus



Figur 3. Täckningsgrader för anmälningsformulären 2023-2024 per **sjukhus, samtliga diagnosregister**. Siffrorna längst ner på staplarna representerar hur många diagnoser som skall vara registrerade i kvalitetsregistret för att uppnå full täckningsgrad (antal i cancerregistret). Antal registrerade i cancerregistret för patienter anmälda från sjukhus utanför norra regionen var 132, 2023-2024 med täckningsgrad 81.1% och 201 patienter var anmälda från primärvården med täckningsgrad 83.6%.

3 Målindikatorer

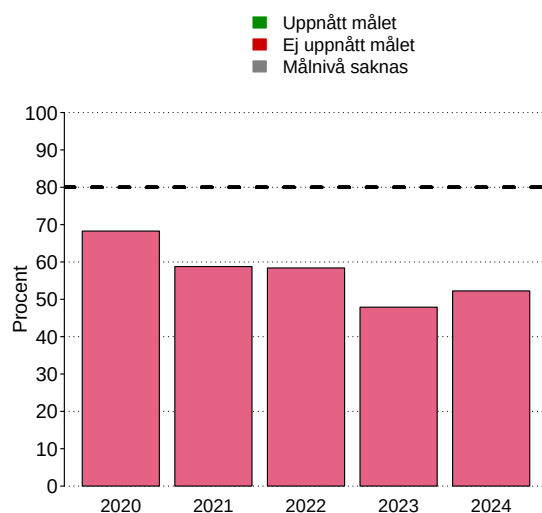
Tidpunkt för måluppfyllelse varierar mellan målindikatorerna, där vissa enligt processplanerna för respektive diagnos/område för 2022-2024 ska uppnås under den perioden, medan tidplanen för vissa mål sträcker sig till 2024 eller senare. För detaljerad information kring olika målindikatorer hänvisas till [processplanerna](#).

Numera finns även omfattande redovisningar av statistik online från de flesta cancerdiagnoser. En del av de indikatorer som redovisas i denna rapport kan även återfinnas i dessa onlinerapporter. Även om indikatorerna ibland är samma så är det inte säkert att siffrorna överensstämmer exakt med denna rapport. Dessa avvikelser kan bero på att statistiken baseras på olika enheter, att olika datumvariabler används eller att datauttagen skett vid olika tidpunkter. Länkar till diagnosspecifik statistik: [interaktiva rapporter](#). För inrapportörer av kvalitetsregisterdata i datalagringssystemet INCA finns också statistik på diagnosnivå och där redovisas uppdaterade data.

För senast redovisade år, dvs 2024, har flera register inte uppnått fullgod täckningsgrad. Därför bör dessa siffror ses som preliminära fram tills täckningsgraden är jämförbar med tidigare år.

3.1 Bröstcancer

Bröstcancer: Andelen patienter med välgrundad misstanke om bröstcancer som opereras inom 4 veckor (nuvarande mål är justerat till 5 veckor). Indikatorn avser primärt opererade fall utan fjärrmetastaser vid diagnos. Uppgifterna redovisas uppdelat på patientens bostadslän. Ett fall per bröst kan rapporterats till Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, vilket innebär att samma person kan finnas med i statistiken två gånger.

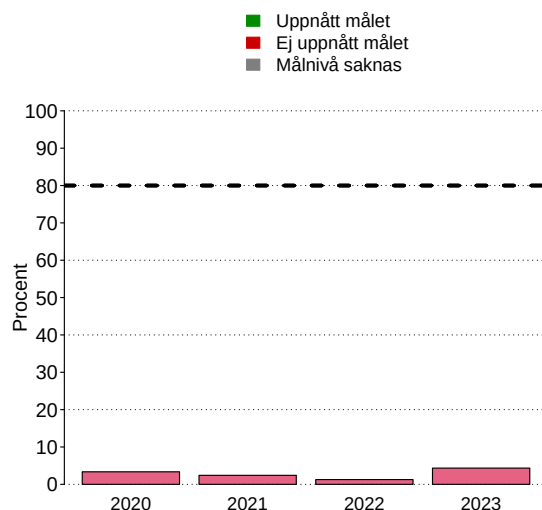


Figur 4. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 1. Andelen med välgrundad misstanke om bröstcancer som opereras inom 4 veckor

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	28	27	7477	7163
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	48	52	666	513
Bostadslän				
Västernorrland	34	44	189	164
Jämtland	31	14	124	14
Västerbotten	35	31	179	172
Norrbotten	88	87	174	163

Bröstcancer: Andelen patienter som ska ha postoperativ behandling med cytostatika och som påbörjar denna inom 24 dagar efter operation. Indikatorn avser primärt opererade fall utan fjärrmetastaser vid diagnos. Operationsdatum är datum för första operation, vilket innebär att tiden från sista operation till start av cytostatikabehandling kan vara kortare än den som redovisas. Uppgifterna redovisas uppdelat på patientens bostadslän. Rapporteringen sker cirka 1 – 1.5 år efter anmälan och därför redovisas data bara tom 2023

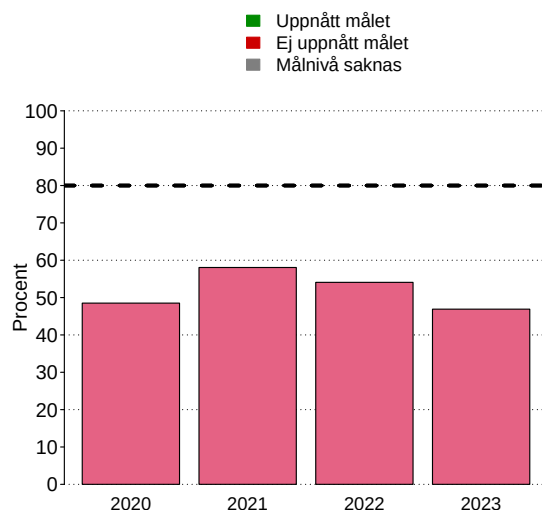


Figur 5. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 2. Väntetid från operation till cytostatikabehandling, andel inom 24 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	4	5	1772	1664
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	1	4	157	161
Bostadslän				
Västernorrland	3	7	39	46
Jämtland	0	9	18	23
Västerbotten	0	2	49	46
Norrbotten	2	2	50	45

Bröstcancer: Andelen patienter som ska ha postoperativ strålbehandling och som påbörjat denna inom 42 dagar efter operation. Indikatorn avser primärt opererade fall utan fjärrmetastaser vid diagnos. Operationsdatum är datum för första operation, vilket innebär att tiden från sista operation till start av cytostatikabehandling kan vara kortare än den som redovisas. Uppgifterna redovisas uppdelat på patientens bostadslän. Rapporteringen sker cirka 1 – 1.5 år efter anmälan och därför redovisas data bara tom 2023.

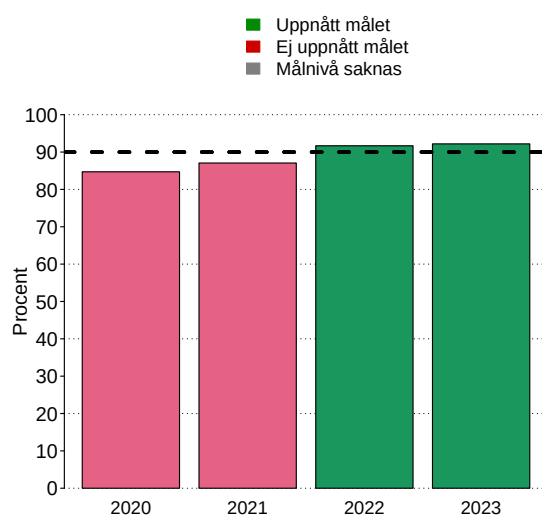


Figur 6. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 3. Väntetid från operation till strålbehandling, andel inom 42 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	14	13	3753	3868
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	54	47	368	371
Bostadslän				
Västernorrland	42	61	118	111
Jämtland	42	45	53	69
Västerbotten	60	48	96	93
Norrbotten	69	31	100	96

Bröstcancer: Andelen patienter med ER-positiv bröstcancer som påbörjar endokrin behandling ska vara högre än 90%. Indikatorn avser opererade östrogenreceptorpositiva invasiva fall utan fjärrmetastaser vid diagnos. Både preoperativ och postoperativ endokrin behandling är medtagna i beräkningen. Redovisade data avser påbörjad behandling. Uppgifterna redovisas uppdelat på patientens bostadslän. Rapporteringen sker cirka 1 – 1.5 år efter anmälan och därför redovisas data bara tom 2023.

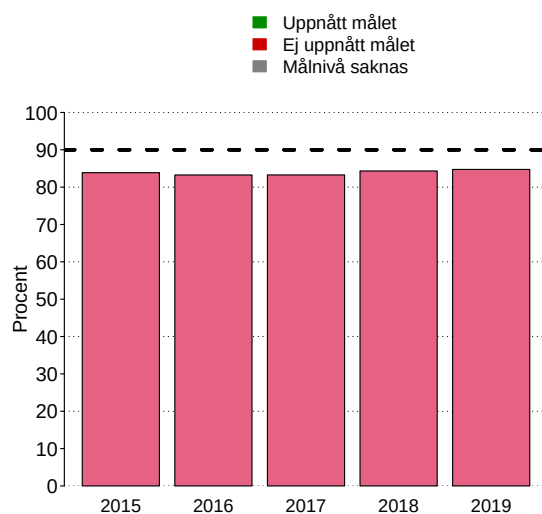


Figur 7. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 4. Andelen patienter med ER-positiv bröstcancer som påbörjar endokrin behandling

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	91	91	6026	6025
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	92	92	541	525
Bostadslän				
Västernorrland	94	96	174	149
Jämtland	94	94	84	86
Västerbotten	89	95	144	150
Norrbotten	90	83	137	137

Bröstcancer: Observerad 5-årsöverlevnad. Indikatorn ger bröstcancerfall som överlevt 5 år efter diagnos. Eftersom en patients överlevnad kan påverkas av många faktorer och där patientens individuella förutsättningar är avgörande bör jämförelser mellan enheter göras med försiktighet. Av den anledningen redovisas bara statistiken ner till sjukvårdsregional nivå. Åren avser diagnosåret.

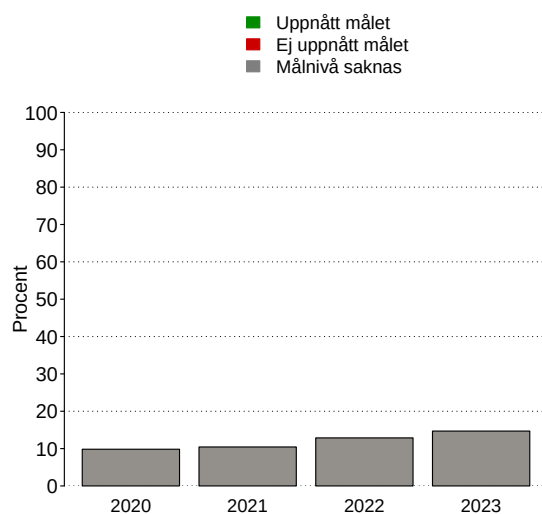


Figur 8. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 5. Observerad 5-årsöverlevnad. Året avser diagnosåret

	Procent		Antal diagnoser	
	2017	2018	2017	2018
Riket				
Riket	84	85	8812	9291
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	84	85	740	806

Bröstcancer: Andelen patienter som får preoperativ onkologisk behandling. Inget målvärde beslutat. Indikatorn avser opererade, invasiva fall utan fjärrmetastaser vid diagnos. Uppgifterna redovisas uppdelat på patientens bostadslän. Rapporteringen av preoperativ cytostatikabehandling sker tillsammans med övrig cytostatikabehandling cirka 1 – 1.5 år efter anmälan och därför redovisas data bara tom 2023.

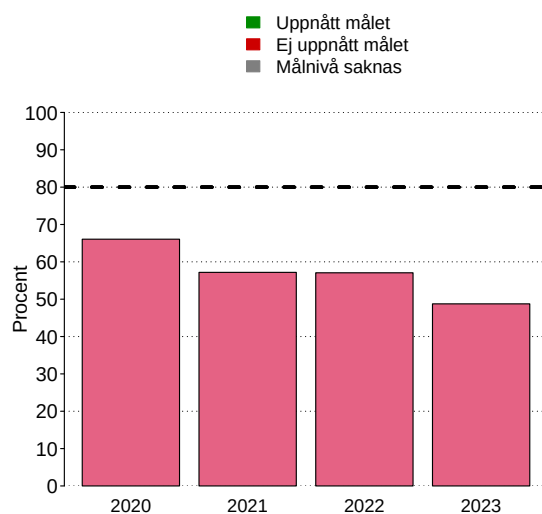


Figur 9. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 6. Andelen patienter som får preoperativ cytostatikabehandling

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	18	18	7604	7812
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	13	15	653	674
Bostadslän				
Västernorrland	22	17	208	190
Jämtland	11	11	94	121
Västerbotten	11	19	178	189
Norrbotten	5	9	172	172

Bröstcancer: Andelen av patienterna som utreds enligt SVF och som håller ledtiden 28 dagar till start av första behandling med kirurgi/ läkemedel/ strålning. Indikatorn avser opererade fall utan fjärrmetastaser vid diagnos. Uppgifterna redovisas uppdelat på patientens bostadslän. Rapporteringen av onkologisk behandling sker cirka 1 – 1.5 år efter anmälan och därför redovisas data bara tom 2023.



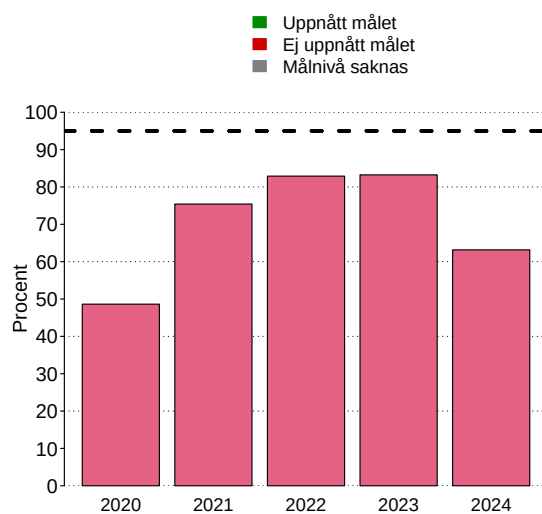
Figur 10. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 7. Tid från välgrundad misstanke om cancer till primär behandling. Andel inom 28 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	36	31	8664	8766
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	57	49	743	761
Bostadslän				
Västernorrland	49	36	241	220
Jämtland	39	31	109	137
Västerbotten	43	38	203	213
Norrbotten	93	88	189	190

3.2 Bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer: Täckningsgraden inom ett år från diagnosdatum baserat på målnivå 95%. Endast patienter som har kunnat följas upp under ett år ingår, vilket gör att för sista året baseras täckningen bara på patienter diagnosiserade tidigare under året. För fullständig täckningsgrad hänvisas till figur 1-3.

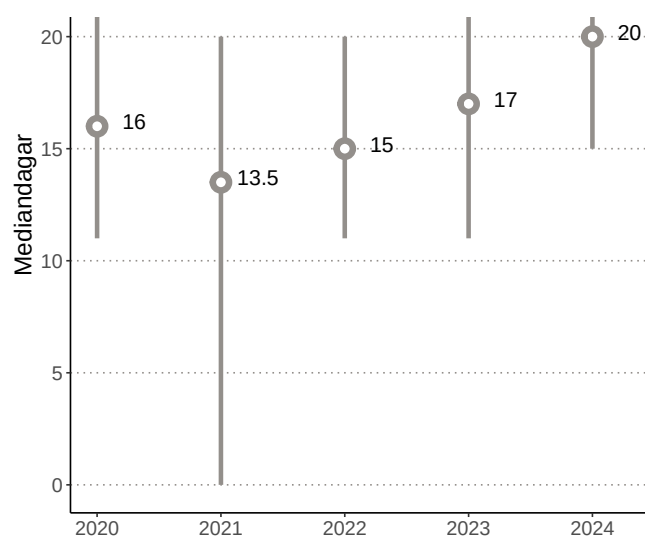


Figur 11. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 8. Anmälningssblanketten med 95 procent täckningsgrad inom 1 år

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	83	63	167	38
Region				
Västernorrland	100	86	35	7
Jämtland	50		10	<5
Västerbotten	80	57	88	21
Norrbotten	82		22	<5
Sjukhus				
Kiruna			<5	<5
Lycksele	80		5	<5
NUS	88	55	75	20
Primärvård			<5	<5
Skellefteå	0		8	<5
Sunderby	86		21	<5
Sundsvall	100	100	23	5
Utomlän	92		12	<5
Örnsköldsvik	100		12	<5
Östersund	50		10	<5

Bukspottkörtelcancer: Medianväntetid från operation till PAD-svar. Statistiken redovisas för riket och sjukvårdsregionen.



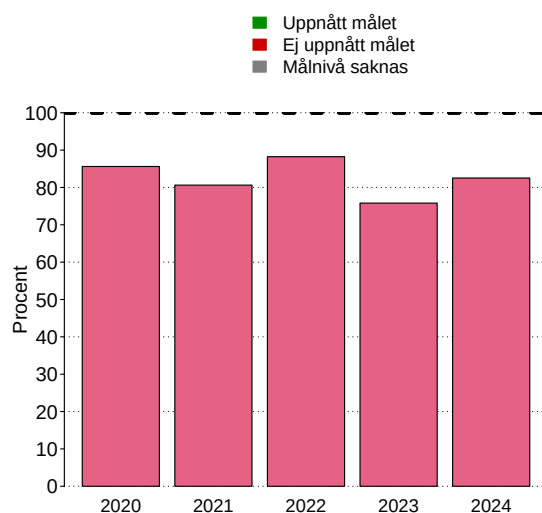
Figur 12. Norra sjukvårdsregionen. 50% av väntetiderna ligger inom lodrät linje.

Tabell 9. Väntetid från operation till PAD-svar

	Mediantid		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	25	22	781	584
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	17	20	63	39

3.3 Hudcancer

Hudcancer: Andel patienter med MM > 1mm som har erbjudits en kontaktsjuksköterska. Sjukhus avser anmälade sjukhus.

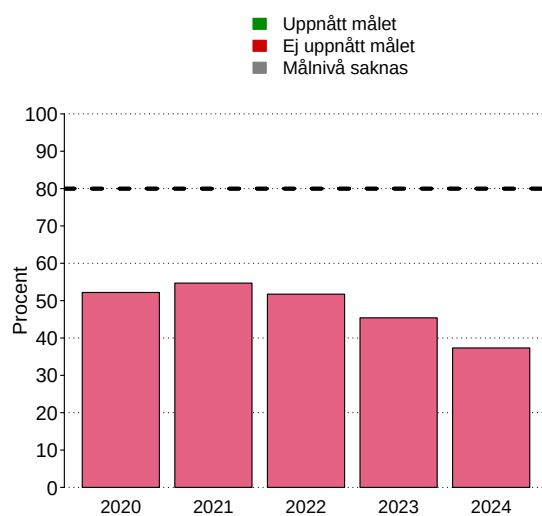


Figur 13. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 10. Andel patienter med MM större än 1 mm som har erbjudits en kontaktsjuksköterska

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	88	87	1855	1615
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	76	83	124	103
Region				
Västernorrland	62	72	37	43
Jämtland	63	67	19	12
Västerbotten	80	96	44	47
Norrbotten	100		24	<5
Sjukhus				
NUS	76	100	25	25
Skellefteå	88	90	8	21
Sunderbyn	100		24	
Sundsvall	69	93	16	27
Östersund	100	88	11	8
Övik			<5	<5
Övr. Jämtland	12		8	<5
Övr. Västerbotten	83		12	<5
Övr. Västernorrland	53	29	17	14

Hudcancer: Andel patienter som opereras inom en vecka från första läkarbesök. Sjukhus avser sjukhus för primär kirurgi.

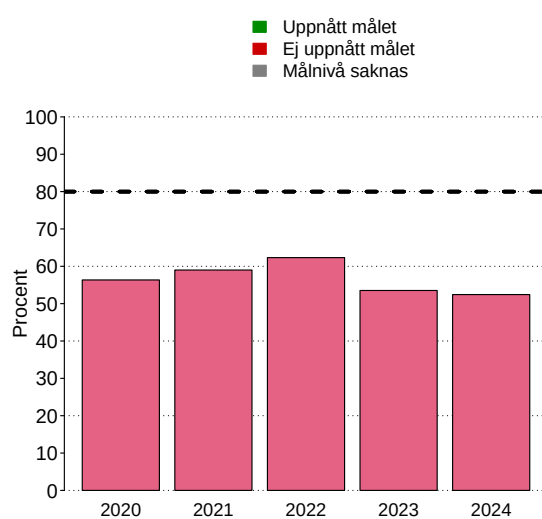


Figur 14. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 11. Andel patienter som opereras inom en vecka från första läkarbesök

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	45	45	5664	5045
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	45	37	315	292
Region				
Västernorrland	45	46	71	79
Jämtland	64	46	64	41
Västerbotten	36	39	118	104
Norrbotten	44	19	62	68
Sjukhus				
Gällivare			<5	<5
Kiruna			<5	<5
NUS	36	39	72	70
Piteå			<5	<5
Skellefteå	57	48	21	33
Sunderbyn	21	10	38	48
Sundsvall	25	33	36	39
Östersund	47	40	38	30
Övik	38	27	8	11
Övr. Jämtland	88	62	24	8
Övr. Norrbotten	89	67	18	12
Övr. Västerbotten	23	33	26	6
Övr. Västernorrland	76	64	29	28

Hudcancer: Andel patienter som väntat mindre än 4 veckor från första läkarbesök till diagnosbesked.
Sjukhus avser anmälade sjukhus.

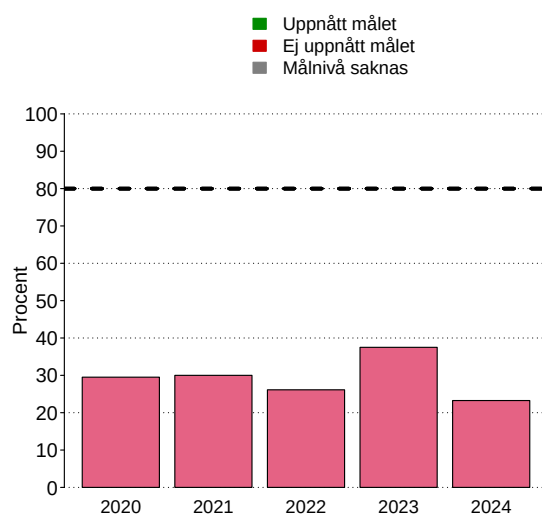


Figur 15. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 12. Andel patienter som väntat mindre än 4 veckor från första läkarbesök till diagnosbesked

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	48	48	5635	5027
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	54	52	312	288
Region				
Västernorrland	51	61	70	79
Jämtland	64	66	64	41
Västerbotten	55	52	119	101
Norrbotten	41	34	59	67
Sjukhus				
Lycksele			<5	
NUS	56	53	77	73
Skellefteå	77	59	22	29
Sunderbyn	38	30	55	57
Sundsvall	45	59	38	41
Östersund	59	61	39	31
Övik	0	36	6	11
Övr. Jämtland	71	75	24	8
Övr. Norrbotten		67	<5	9
Övr. Västerbotten	30		20	<5
Övr. Västernorrland	78	69	27	26

Hudcancer: Andel patienter med MM > 1mm som genomgår utvidgad kirurgi inom 3 veckor efter PAD-svar. Sjukhus avser sjukhus för primär kirurgi.



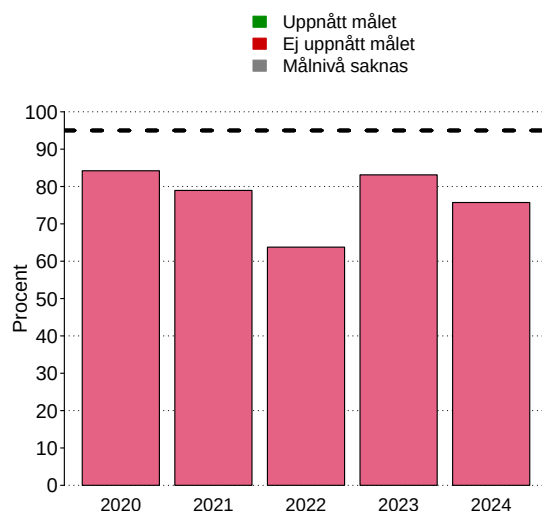
Figur 16. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 13. Andel patienter med MM > 1 mm som genomgår utvidgad kirurgi inom 3 veckor efter PAD-svar

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	33	33	1586	1259
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	38	23	104	86
Region				
Västernorrland	37	17	30	29
Jämtland	48	55	21	11
Västerbotten	26	20	35	45
Norrbotten	50		18	<5
Sjukhus				
Gällivare			<5	
NUS	22	32	18	22
Skellefteå	12	10	8	21
Sunderbyn	33		9	
Sundsvall	33	18	12	22
Östersund	40	57	10	7
Övik			<5	<5
Övr. Jämtland	55		11	<5
Övr. Norrbotten	62		8	
Övr. Västerbotten	44		9	<5
Övr. Västernorrland	44	0	16	6

3.4 Cancer i lever och gallvägar

Cancer i lever och gallvägar: Täckningsgraden inom ett år från diagnosdatum baserat på målnivå 95%. Endast patienter som har kunnat följas upp under ett år ingår, vilket gör att för sista året baseras täckningen bara på patienter diagnosiserade tidigare under året. För fullständig täckningsgrad hänvisas till figur 1-3. Det är endast diagnosgrupperna hepatocellulär cancer i lever, kolangiocellulär cancer i intra hepatiska gallvägar och gallblåsa som ingår i beräkningarna.



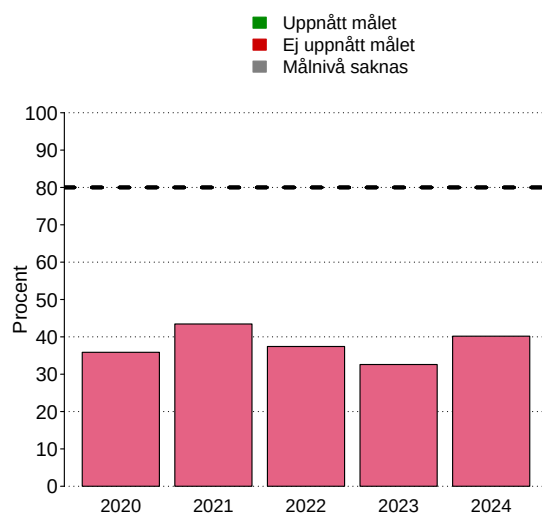
Figur 17. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 14. Anmälningssblanketten med 95 procent täckningsgrad inom 1 år

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	83	76	77	70
Region				
Västernorrland	100	82	24	11
Jämtland		12	<5	8
Västerbotten	79	85	34	33
Norrbotten	82	83	11	12
Sjukhus				
Lycksele			<5	<5
NUS	84	87	31	30
Piteå			<5	<5
Primärvård			<5	<5
Skellefteå			<5	<5
Sunderby	82	83	11	12
Sundsvall	100	75	19	8
Utomlän		83	<5	6
Örnsköldsvik	100		5	<5
Östersund		12	<5	8

3.5 Lung- och lundsäckscancer

Lung- och lundsäckscancer: Andel lungcancerfall där antal dagar mellan behandlingsbeslut och behandlingsstart för patienter planerade för kirurgi eller strålbehandling är mindre än 14 dagar.

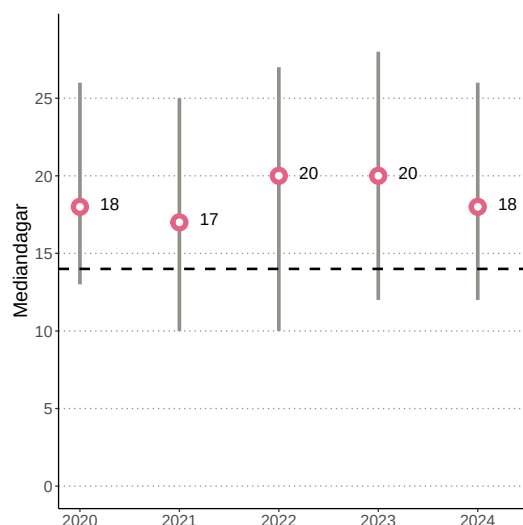


Figur 18. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 15. Väntetid för behandlingsbeslut till behandlingsstart (Kirurgi/RT) < 14 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	27	28	1863	1391
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	33	40	135	112
Region				
Västernorrland	30	38	30	34
Jämtland	38	35	32	17
Västerbotten	39	59	33	29
Norrbotten	25	28	40	32
Sjukhus				
NUS	39	59	33	29
Sunderbyn	25	28	40	32
Sundsvall	29	38	31	34
Östersund	38	35	32	17

Lung- och lungsäckscancer: Mediantid för lungcancerfall där antal dagar mellan behandlingsbeslut och behandlingsstart för patienter planerade för kirurgi eller strålbehandling ska vara mindre än 14 dagar.

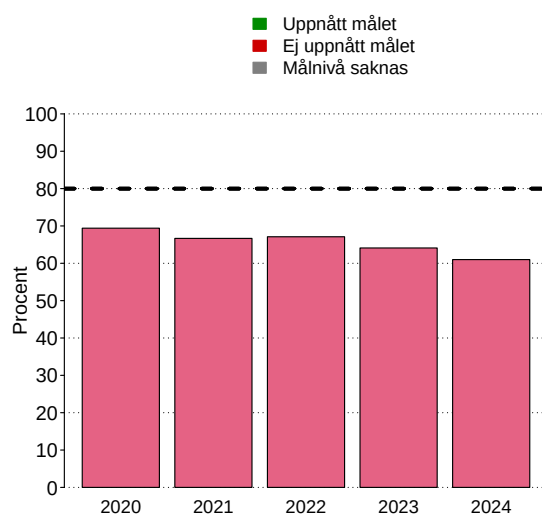


Figur 19. Norra sjukvårdsregionen. 50% av väntetiderna ligger inom lodrät linje.

Tabell 16. Medianväntetid från behandlingsbeslut till behandlingsstart (kirurgi, strålbehandling)

	Mediantid		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	22	21	1863	1391
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	20	18	135	112
Region				
Västernorrland	21	20	30	34
Jämtland	21	20	32	17
Västerbotten	16	13	33	29
Norrbotten	26	21	40	32
Sjukhus				
NUS	16	13	33	29
Sunderbyn	26	21	40	32
Sundsvall	22	20	31	34
Östersund	21	20	32	17

Lung- och lungsäckscancer: Andel lungcancerfall som planeras för läkemedel där antal dagar mellan behandlingsbeslut till behandlingsstart är mindre än 10 dagar.

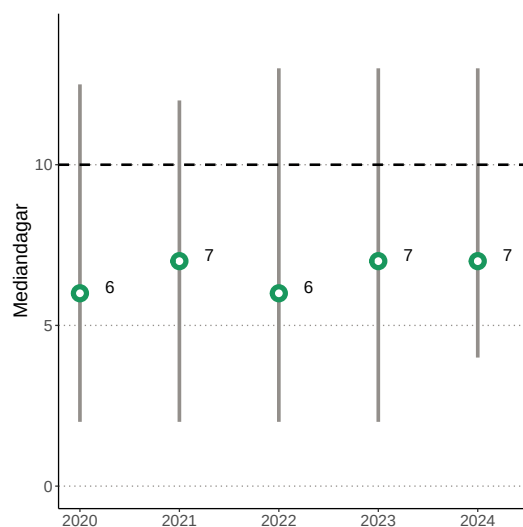


Figur 20. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 17. Väntetid för behandlingsbeslut till behandlingsstart om Läkemedel < 10 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	55	56	1850	1270
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	64	61	156	141
Region				
Västernorrland	54	55	35	42
Jämtland	70	82	20	17
Västerbotten	63	53	38	38
Norrbotten	68	64	63	45
Sjukhus				
NUS	62	51	39	35
Sunderbyn	69	66	62	47
Sundsvall	54	55	35	42
Östersund	70	82	20	17

Lung- och lungsäckscancer: Mediantid för lungcancerfall som planeras för läkemedel där antal dagar mellan behandlingsbeslut till behandlingsstart ska vara mindre än 10 dagar.

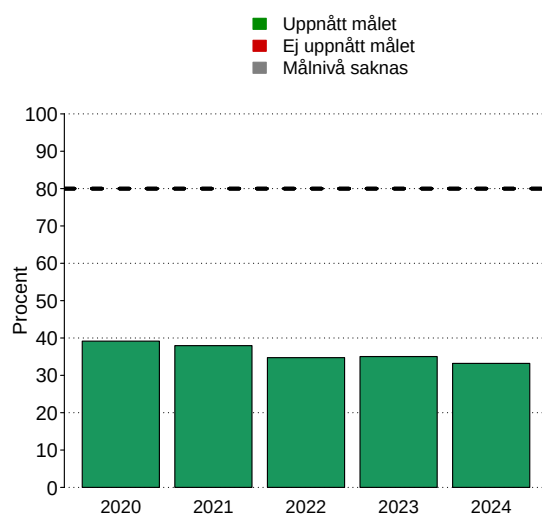


Figur 21. Norra sjukvårdsregionen. 50% av väntetiderna ligger inom lodrät linje.

Tabell 18. Väntetid från behandlingsbeslut till behandlingsstart om Läkemedel-medianid

	Mediantid		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	9	8	1850	1268
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	7	7	156	141
Region				
Västernorrland	7	8	35	42
Jämtland	6	6	20	17
Västerbotten	8	10	38	38
Norrbotten	6	6	63	45
Sjukhus				
NUS	8	10	39	35
Sunderbyn	6	6	62	47
Sundsvall	7	8	35	42
Östersund	6	6	20	17

Lung- och lungsäckscancer: Andel fall där antal dagar mellan inremiss och start av behandling ska vara 44 dagar eller lägre.

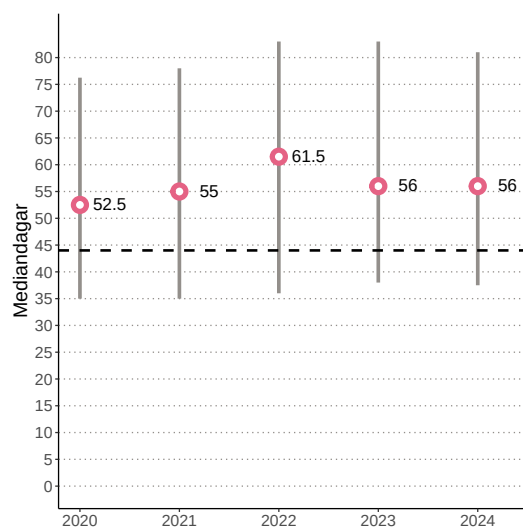


Figur 22. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 19. Väntetid för inremiss till behandlingsstart
≤ 44 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	26	27	3756	2670
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	35	33	294	250
Region				
Västernorrland	30	23	67	77
Jämtland	28	53	53	32
Västerbotten	37	34	71	65
Norrbotten	41	35	103	77
Sjukhus				
NUS	36	31	72	62
Sunderbyn	41	37	102	79
Sundsvall	29	23	68	77
Östersund	28	53	53	32

Lung- och lungsäckscancer: Mediantiden för antal dagar mellan inremiss och start av behandling ska vara 44 dagar eller lägre

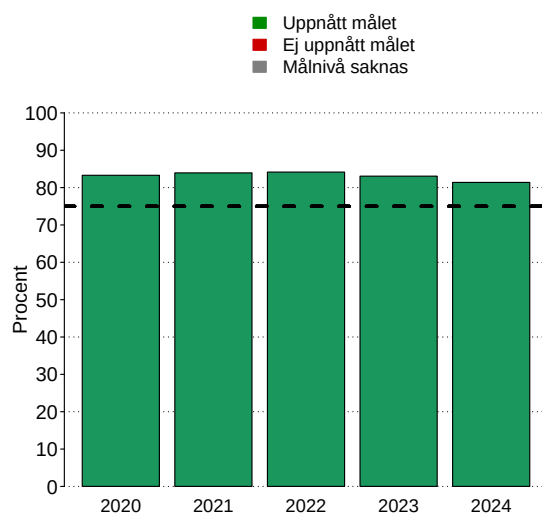


Figur 23. Norra sjukvårdsregionen. 50% av väntetiderna ligger inom lodrät linje.

Tabell 20. Väntetid för inremiss till behandlingsstart-mediantid

	Mediantid		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	65	63	3755	2664
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	56	56	294	250
Region				
Västernorrland	59	59	67	77
Jämtland	56	44	53	32
Västerbotten	55	58	71	65
Norrbotten	54	53	103	77
Sjukhus				
NUS	54	59	72	62
Sunderbyn	54	53	102	79
Sundsvall	60	59	68	77
Östersund	56	44	53	32

Lung- och lungsäckscancer: Andel fall med lungcancer där multidisciplinär konferens (mdk) genomförts

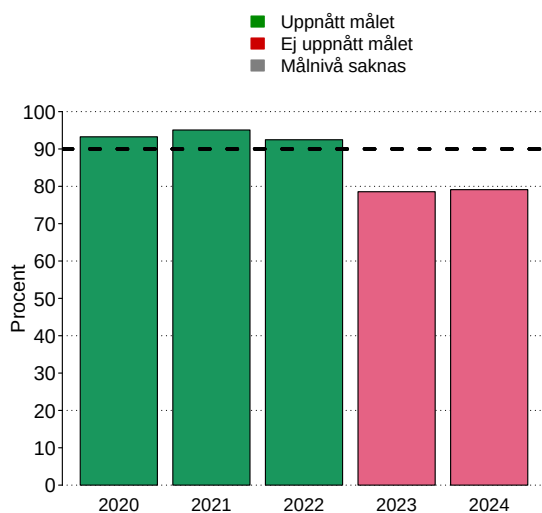


Figur 24. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 21. Andel fall där multidisciplinär konferens genomförts

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	83	83	4799	3404
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	83	81	372	360
Region				
Västernorrland	74	73	93	113
Jämtland	82	72	62	60
Västerbotten	91	96	95	89
Norrbotten	84	85	122	99
Sjukhus				
Lycksele			<5	<5
NUS	92	96	95	84
Sunderbyn	84	85	121	101
Sundsvall	74	73	94	113
Östersund	82	72	62	60

Lung- och lungsäckscancer: Andel fall med lungcancer som har tilldelats kontaktsjuksköterska.



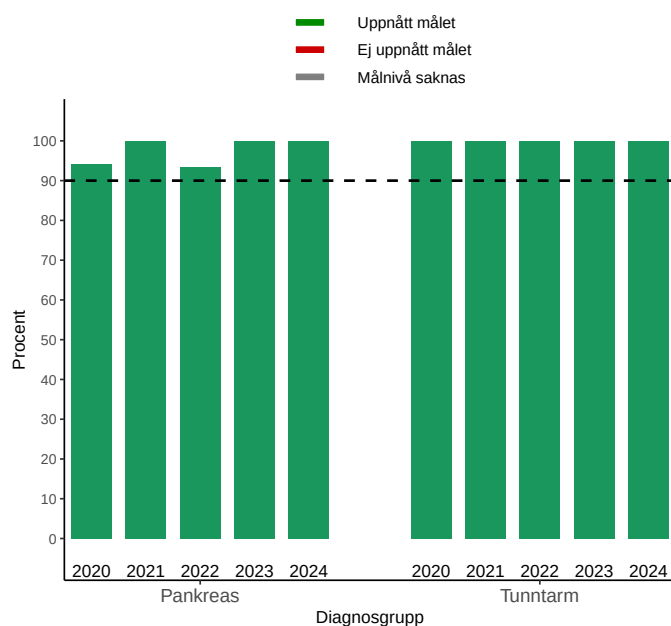
Figur 25. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 22. Andel fall som har tilldelats kontaktsjuksköterska

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	87	86	4802	3403
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	79	79	373	359
Region				
Västernorrland	96	91	93	113
Jämtland	97	95	62	60
Västerbotten	28	38	96	88
Norrbotten	96	93	122	99
Sjukhus				
Lycksele			<5	<5
NUS	28	37	96	83
Sunderbyn	97	92	121	101
Sundsvall	96	91	94	113
Östersund	97	95	62	60

3.6 Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET): Andel patienter som genomgått MDK i norra sjukvårdsregionen ska vara minst 90%.

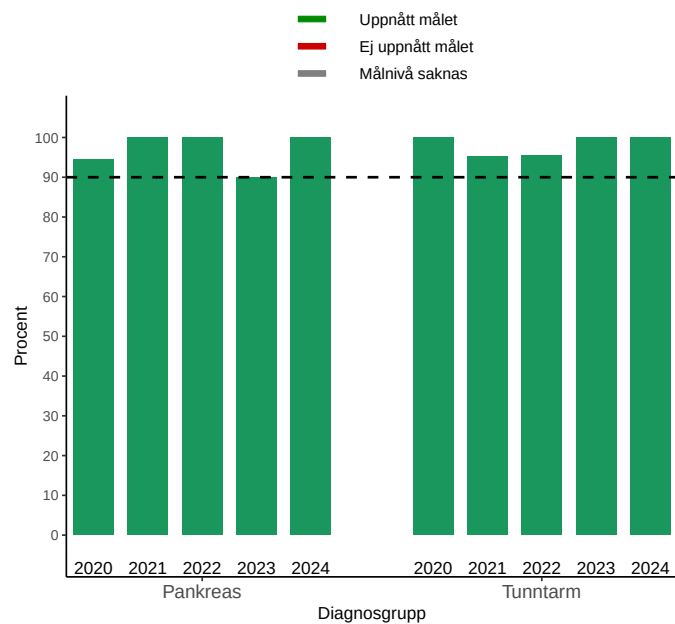


Figur 26. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 23. Patienter som genomgått MDK

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Pankreas	100	100	10	7
Tunntarm	100	100	22	12

Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET): Andelen patienter som erbjudits namngiven kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen ska vara minst 90%.



Figur 27. Norra sjukvårdsregionen

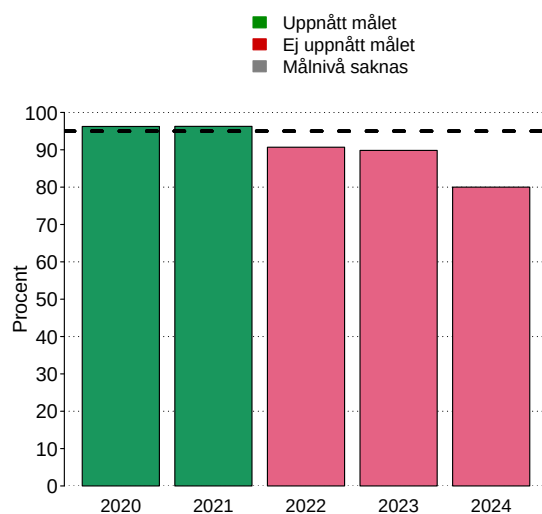
Tabell 24. Patienter som erbjudits namngiven kontaktsjuksköterska

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Pankreas	90	100	10	7
Tunntarm	100	100	22	12

3.7 Matstrupe/Magsäckscancer

Indikatorn Medianväntetid från operation till pad-svar skall vara inom 21 dagar har utgått från rapporten eftersom datum för pad-svar inte längre registreras

Matstrupe/Magsäckscancer: Täckningsgraden inom ett år från diagnosdatum baserat på målnivå 95%. Endast patienter som har kunnat följas upp under ett år ingår, vilket gör att för sista året baseras täckningen bara på patienter diagnoserade tidigare under året. För fullständig täckningsgrad hänvisas till figur 1-3.



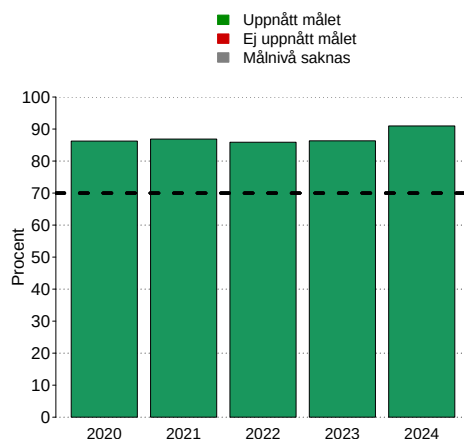
Figur 28. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 25. Anmälningssblanketten med 95 procent täckningsgrad inom 1 år

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	90	80	236	60
Region				
Västernorrland	70	50	37	20
Jämtland	79	75	38	8
Västerbotten	99	100	85	16
Norrbotten	97	100	74	16
Sjukhus				
Kiruna			<5	<5
Lycksele	100		10	<5
NUS	98	100	63	14
Skellefteå	100		12	<5
Sollefteå			<5	<5
Sunderby	97	100	74	16
Sundsvall	50	38	20	16
Utomlän			<5	<5
Örnsköldsvik	100		16	<5
Östersund	79	75	38	8

3.8 Palliativa registret

Palliativa registret: I redovisningen ingår individer där grundsjukdomen är cancer. Brytpunktssamtal – Målnivå 70%. Brytpunktssamtal hålls när all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård.

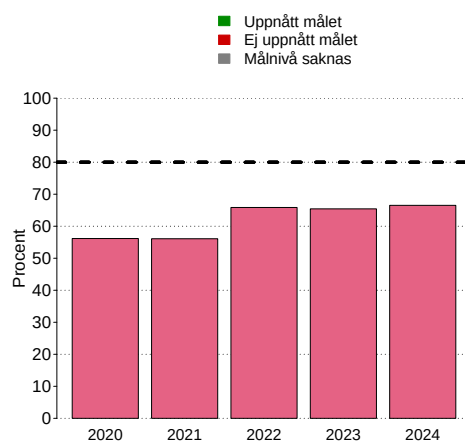


Figur 29. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 26. Brytpunktssamtal genomförd

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	86	91	1308	1328
Region				
Västernorrland	92	94	365	403
Jämtland	91	92	184	195
Västerbotten	86	91	391	423
Norrbotten	79	87	368	307

Palliativa registret: I redovisningen ingår individer där grundsjukdomen är cancer. Användning av validerat smärtskattningsinstrument – Målnivå 80%. Indikatorn visar andelen patienter vars smärta skattats med ett smärtskattningsinstrument.

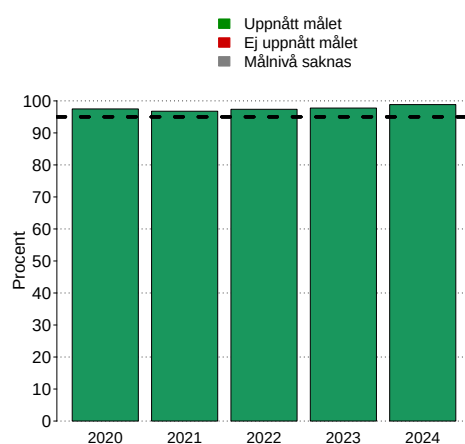


Figur 30. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 27. Användning av validerat smärtskattningsinstrument

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	65	67	1611	1646
Region				
Västernorrland	62	62	441	468
Jämtland	57	58	232	248
Västerbotten	74	72	471	522
Norrbotten	64	69	467	408

Palliativa registret: I redovisningen ingår individer där grundsjukdomen är cancer. Ordination av stark opioid i injektionsform – Målnivå 95%.

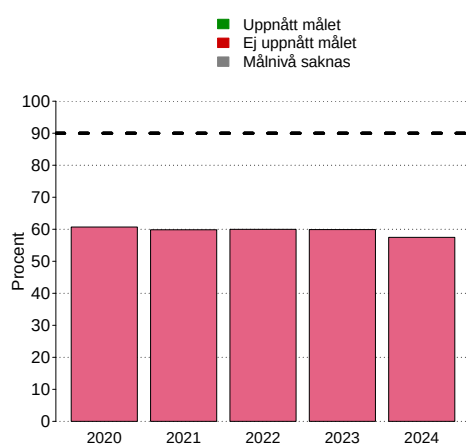


Figur 31. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 28. Ordination av stark opioid i injektionsform

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	98	99	1611	1646
Region				
Västernorrland	99	99	441	468
Jämtland	100	100	232	248
Västerbotten	98	98	471	522
Norrbotten	96	99	467	408

Palliativa registret: I redovisningen ingår individer där grundsjukdomen är cancer. Bedömd munhälsa
– Målnivå 90%.

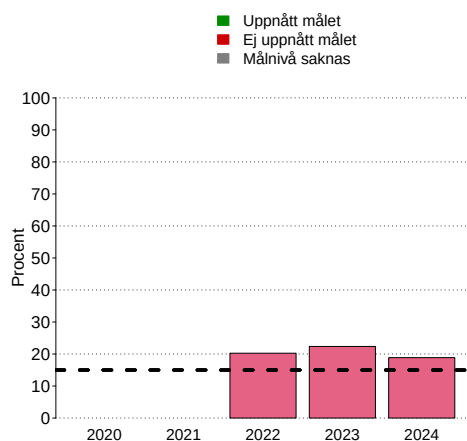


Figur 32. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 29. Bedömd munhälsa

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	60	57	1611	1646
Region				
Västernorrland	63	60	441	468
Jämtland	50	51	232	248
Västerbotten	66	58	471	522
Norrbotten	56	58	467	408

Palliativa registret: I redovisningen ingår individer där grundsjukdomen är cancer. Med start 2022 redovisas andel dödsplats efterfrågades ej”, vars andel skall understiga 15%.

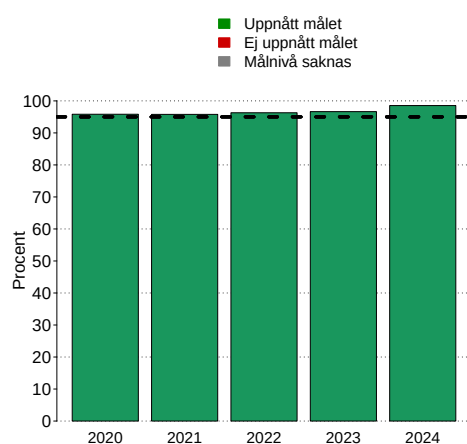


Figur 33. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 30. Önskemål om dödsplats känt

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	22	19	1413	1362
Region				
Västernorrland	11	9	386	399
Jämtland	14	18	203	202
Västerbotten	22	14	417	426
Norrbotten	37	38	407	335

Palliativa registret: I redovisningen ingår individer där grundsjukdomen är cancer. Ordination av injektionsläkemedel mot ångest– Målnivå 95%.



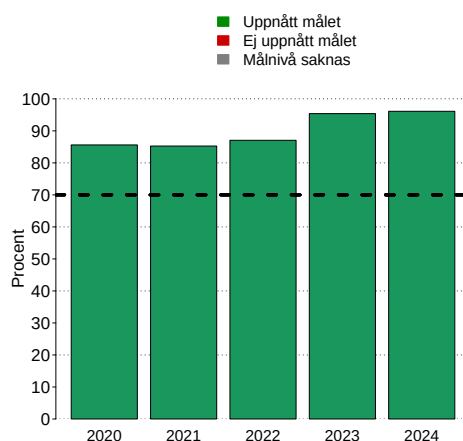
Figur 34. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 31. Ordination av injektionsläkemedel mot ångest

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	97	99	1611	1646
Region				
Västernorrland	98	99	441	468
Jämtland	97	100	232	248
Västerbotten	97	98	471	522
Norrbotten	94	98	467	408

3.9 Prostatacancer

Prostatacancer: Andel män med prostatacancer som tilldelats kontaktsjuksköterska skall vara högre än 70%. I SoS NR motsvaras indikatorn av indikator 1.10, som är en allmän indikator för många cancerformer. SoS målnivå är 100% (sida 34 i Målnivåer). Eftersom patienten ibland byter vårdgivare under vårdprocessen finns möjlighet att rapportera på samtliga formulär. Det räcker att en vårdgivare har angivit kontaktsjuksköterska för att indikatorn ska anses vara uppfylld. För ytterligare information om kontaktsköterskans uppgifter se: [Referens kontaktsjuksköterska](#).

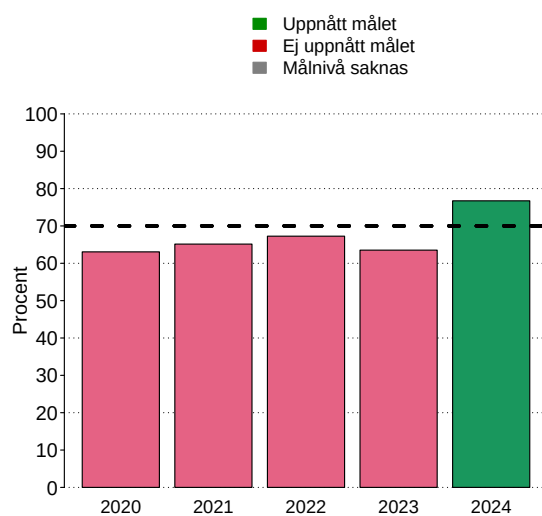


Figur 35. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 32. Andel män med prostatacancer som tilldelats kontaktsjuksköterska

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	88	89	10792	9351
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	95	96	780	849
Region				
Västernorrland	99	99	267	300
Jämtland	99	100	152	151
Västerbotten	98	99	312	317
Norrbotten	47	68	49	81
Sjukhus				
Kalix	0	17	18	12
Kiruna	80	100	15	23
Lycksele	94	100	48	38
NUS	98	99	196	204
Skellefteå	100	100	68	75
Sunderbyn	69	65	16	46
Sundsvall	99	99	252	287
Östersund	99	100	152	151
Övik	100	92	15	13

Prostatacancer: Andel som har rapporterat ePROM-enkät 1 år efter kurativ behandling skall vara högre än 70%.

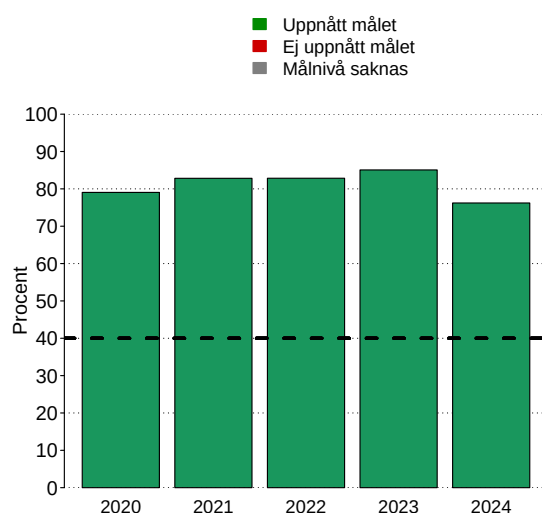


Figur 36. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 33. Andel som har rapporterat ePROM-enkät 1 år efter kurativ behandling

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	75	79	6822	1426
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	64	77	477	116
Region				
Västernorrland	70	69	125	36
Jämtland	69	94	108	16
Västerbotten	56	73	165	41
Norrbotten	62	82	79	22
Sjukhus				
NUS	55	74	243	57
Sundsvall	70	69	159	36
Östersund	81	100	53	12

Prostatacancer: Andel män högst 80 år med högriskcancer eller cancer med mycket hög risk utan fjärrmetastaser som diskuterats på MDK skall vara högre än 40%. Definitionen av multidisciplinärkonferens i NPCR är att urolog och onkolog deltar.

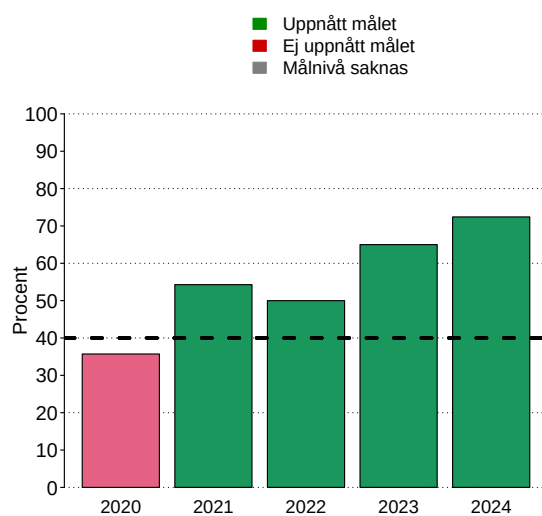


Figur 37. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 34. Multidisciplinär konferens/mottagning (högrisk/mycket hög risk)

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	86	84	2234	1885
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	85	76	154	185
Region				
Västernorrland	93	82	67	89
Jämtland	69	61	26	18
Västerbotten	93	79	43	53
Norrbotten	65	60	17	25
Sjukhus				
Kalix	56	80	9	5
Kiruna	60		5	<5
Lycksele	71	83	7	6
NUS	96	78	27	40
Skellefteå	100	77	9	13
Sunderbyn		40	<5	15
Sundsvall	92	84	63	86
Östersund	67	54	24	13
Övik			<5	<5

Prostatacancer: Väntetid från operationsanmälan till operation som primärbehandling för män med högriskcancer eller cancer med mycket hög risk. Andel inom 28 dagar skall vara högre än 40%.

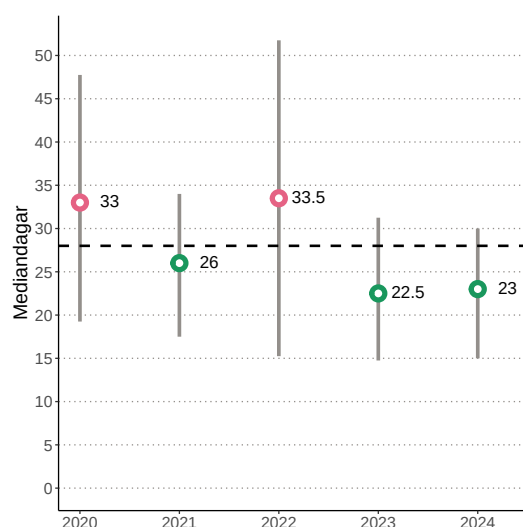


Figur 38. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 35. Väntetid från beslut till operation (hög-risk/mycket hög risk), andel inom 28 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	59	61	533	476
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	65	72	20	29
Region				
Västernorrland		83	<5	6
Jämtland	86		7	<5
Västerbotten	50	50	8	10
Norrbotten		82	<5	11
Sjukhus				
NUS	50	50	10	10
Sundsvall			<5	<5
Östersund	80		5	<5

Prostatacancer: Väntetid från operationsanmälan till operation som primärbehandling för män med högriskcancer eller cancer med mycket hög risk, mediantid inom 28 dagar.

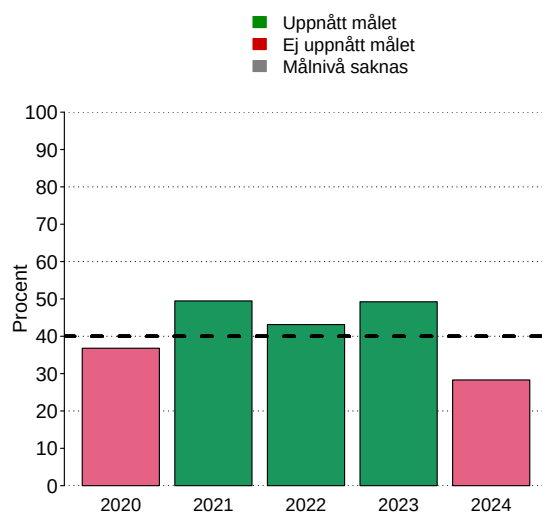


Figur 39. Norra sjukvårdsregionen. 50% av väntetiderna ligger inom lodrät linje.

Tabell 36. Väntetid från beslut till operation (hög-risk/mycket hög risk), median

	Mediantid		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	25	25	533	476
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	22	23	20	29
Region				
Västernorrland		23	<5	6
Jämtland	16		7	<5
Västerbotten	28	29	8	10
Norrbotten		17	<5	11
Sjukhus				
NUS	29	29	10	10
Sundsvall			<5	<5
Östersund	14		5	<5

Prostatacancer: Väntetid från behandlingsbeslut hos onkolog till strålbehandling (utan neoadjuvant hormonbehandling) som primärbehandling för män med mellanriskcancer. Andel inom 30 dagar skall vara högre än 40%.

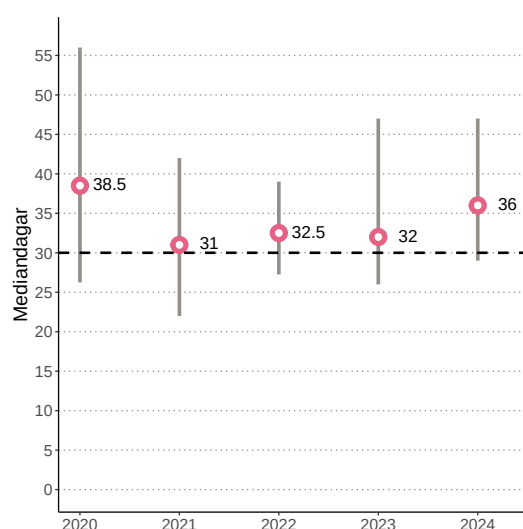


Figur 40. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 37. Väntetid från beslut till strålbehandling (mellanrisk), andel inom 30 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	19	17	612	357
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	49	28	65	53
Region				
Västernorrland	20	20	5	5
Jämtland	35		17	<5
Västerbotten	65	30	34	30
Norrbotten	33	21	9	14
Sjukhus				
NUS	60	30	43	46
Sundsvall	29	29	21	7

Prostatacancer: Väntetid från behandlingsbeslut hos onkolog till strålbehandling (utan neoadjuvant hormonbehandling) som primärbehandling för män med mellanriskcancer, mediantid inom 30 dagar.

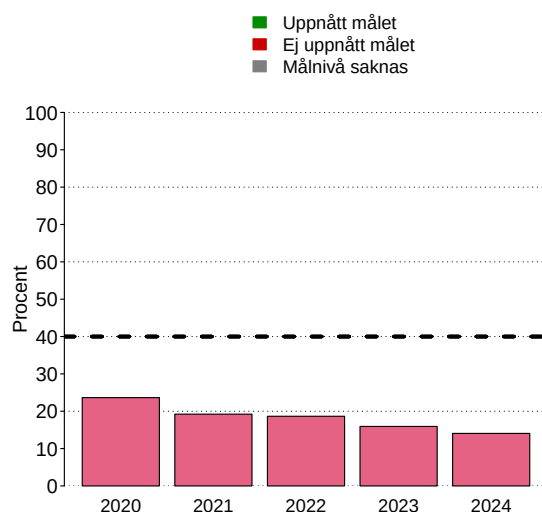


Figur 41. Norra sjukvårdsregionen. 50% av väntetiderna ligger inom lodrät linje.

Tabell 38. Väntetid från beslut till strålbehandling (mellanrisk), median

	Mediantid		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	47	47	612	357
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	32	36	65	53
Region				
Västernorrland	36	34	5	5
Jämtland	37		17	<5
Västerbotten	28	40	34	30
Norrbotten	42	34	9	14
Sjukhus				
NUS	28	36	43	46
Sundsvall	37	34	21	7

Prostatacancer: Väntetid från provtagning till PAD-besked till patient, andel inom 11 dagar skall vara högre än 40%. I SVF anges att möte ska ske med patienten högst elva dagar efter biopsitagning. I NPCR registreras om denna väntetid var förlängd pga. patientens val. NPCR registrerar också om information gavs vid mottagningsbesök, via telefon, eller brev.

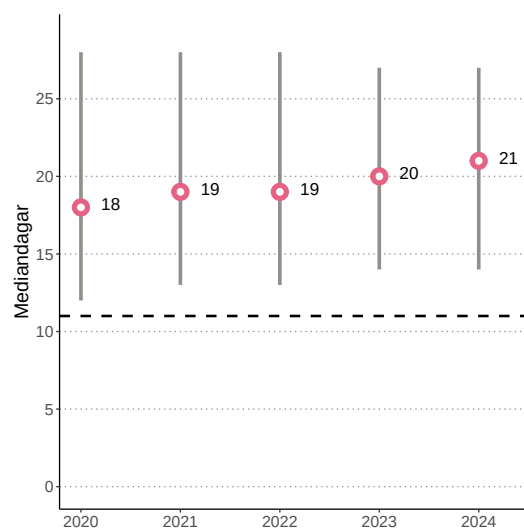


Figur 42. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 39. Väntetid från provtagning till PAD-besked till patient, andel inom 11 dagar

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	11	15	10272	8598
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	16	14	747	768
Region				
Västernorrland	32	30	259	281
Jämtland	6	4	147	155
Västerbotten	6	4	309	296
Norrbotten	23	19	30	36
Sjukhus				
Kalix	6	8	18	12
Kiruna	43	14	14	22
Lycksele	8	7	49	41
NUS	6	2	188	172
Skellefteå	7	4	70	81
Sundsvall	34	31	243	272
Östersund	6	3	137	151
Övik	0	0	15	11

Prostatacancer: Väntetid från provtagning till PAD-besked till patient, mediantid inom 11 dagar. I SVF anges att möte ska ske med patienten högst elva dagar efter biopsitagning. I NPCR registreras om denna väntetid var förlängd pga. patientens val. NPCR registrerar också om information gavs vid mottagningsbesök, via telefon, eller brev.



Figur 43. Norra sjukvårdsregionen. 50% av väntetiderna ligger inom lodrät linje.

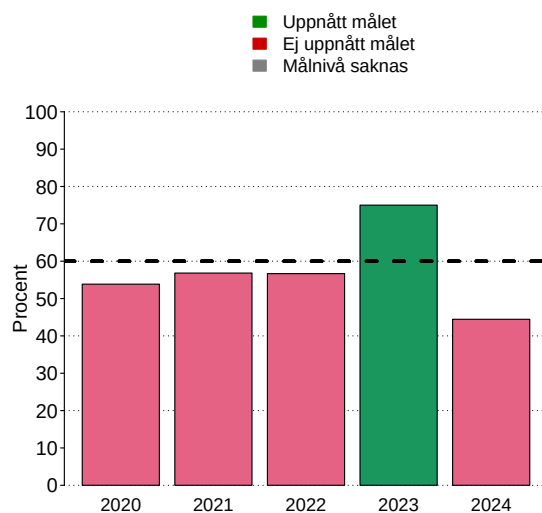
Tabell 40. Väntetid från provtagning till PAD-besked till patient, median

	Mediantid		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	19	19	10272	8598
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	20	21	747	768
Region				
Västernorrland	15	15	259	281
Jämtland	21	25	147	155
Västerbotten	21	21	309	296
Norrbotten	14	20	30	36
Sjukhus				
Kalix	14	14	18	12
Kiruna	14	21	14	22
Lycksele	28	30	49	41
NUS	21	21	188	172
Skellefteå	22	21	70	81
Sundsvall	14	14	243	272
Östersund	21	25	137	151
Övik	25	26	15	11

3.10 Sköldkörtelcancer

Enligt beslut från registergruppen redovisas ej öppen statistik på sjukhusnivå.

Sköldkörtelcancer: Preoperativ fastställd malignitet. Endast papillär eller medullär cancer om patologisk T-stadium $\geq$ T1b. Målnivå 60% (enligt cancerplanen för norra regionen 2022-2024).

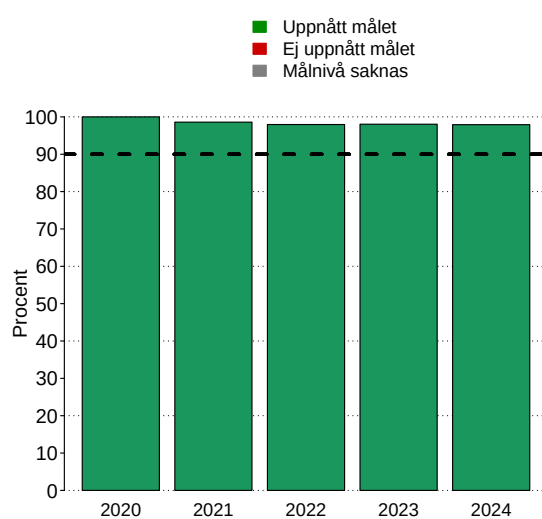


Figur 44. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 41. Preoperativ fastställd malignitet

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	68	64	283	169
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	75	44	32	27

Sköldkörtelcancer: Behandlingsbeslut taget på multidisciplinär konferens (MDK). Endast patienter med patologisk T-stadium $\geq$ T1b. Målnivå 90%.

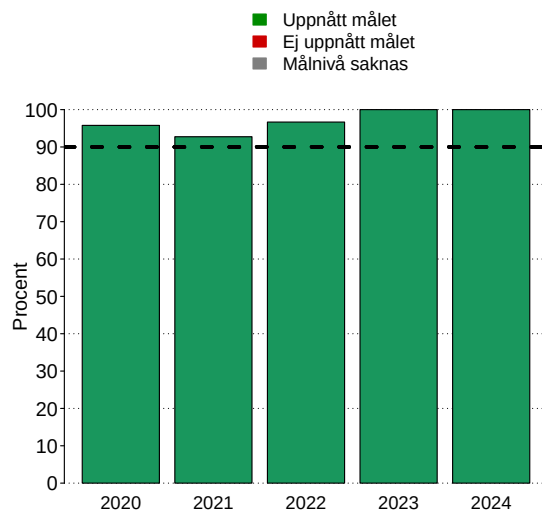


Figur 45. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 42. Behandlingsbeslut taget på multidisciplinär konferens (MDK)

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	96	97	435	252
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	98	98	51	48

Sköldkörtelcancer: Namngiven kontaktsjuksköterska skall finnas för 90% av patienterna.



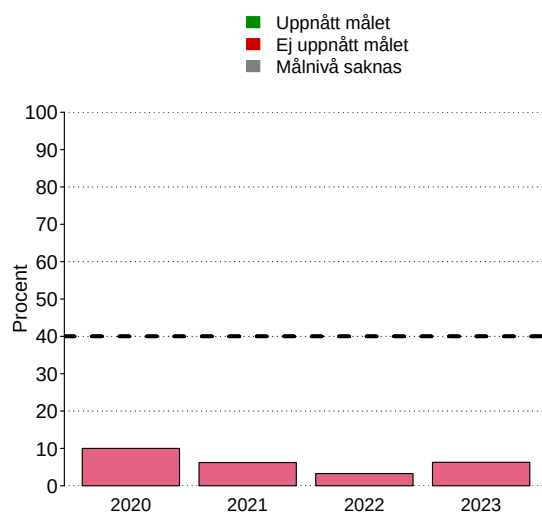
Figur 46. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 43. Namngiven kontaktsjuksköterska skall finnas för 90% av patienterna

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	92	87	663	383
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	100	100	84	65

3.11 Tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer: Andelen tjocktarmscancer som inkluderats i studie (klinisk eller onkologisk) skall vara högre än 40% (cancerplanen 2022-2024). På sjukhusnivå redovisas resultat för opererande sjukhus. Data redovisas bara till och med 2023 pga eftersläpning i registreringen av onkologisk behandling.

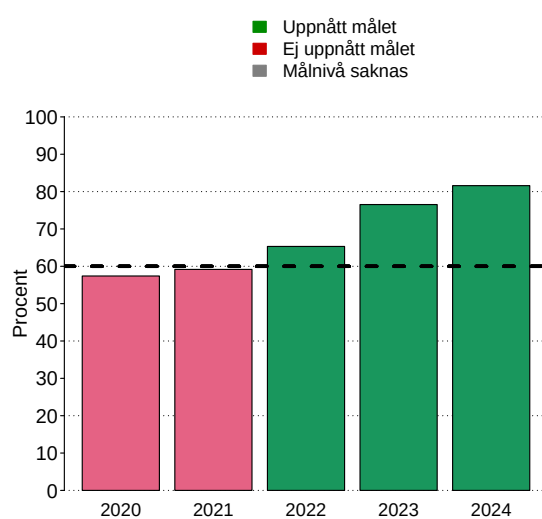


Figur 47. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 44. Tjocktarmscancer: Inkluderad i studie

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	19	17	4081	4057
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	3	6	368	398
Region				
Västernorrland	7	4	94	108
Jämtland	0	0	54	61
Västerbotten	4	15	121	137
Norrbotten	0	0	99	92
Sjukhus				
Lycksele			<5	<5
NUS	5	20	73	66
Skellefteå	2	11	47	70
Sunderbyn	0	0	99	92
Sundsvall	13	6	52	66
Östersund	0	0	54	61
Övik	0	0	42	42

Tjocktarmscancer: Andelen minimalinvasiv kirurgi (laparoskopiskt opererade) skall vara högre än 60%. På sjukhusnivå redovisas resultat för opererande sjukhus.

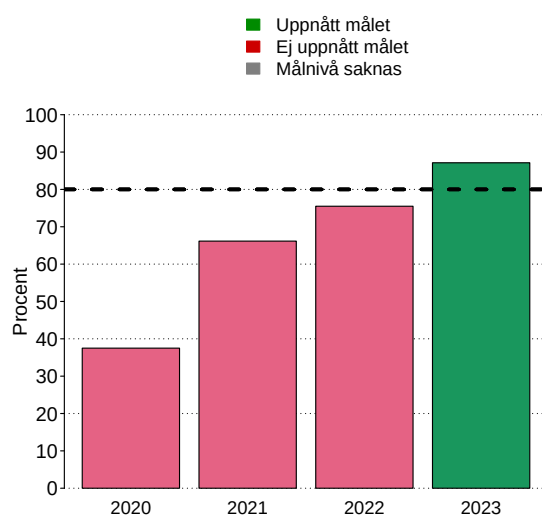


Figur 48. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 45. Tjocktarmscancer: Minimalinvasiv kirurgi genomförd

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	73	77	5153	4375
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	77	82	473	364
Region				
Västernorrland	82	88	124	96
Jämtland	72	73	61	59
Västerbotten	71	87	168	112
Norrbotten	80	75	120	97
Sjukhus				
Lycksele			<5	
NUS	73	84	114	92
Skellefteå	70	100	53	20
Sunderbyn	80	75	120	97
Sundsvall	74	86	82	59
Östersund	72	73	61	59
Övik	98	89	42	37

Tjocktarmscancer: Andelen tjocktarmscancerpatienter som genomgått MMR/MSI-analys någon gång (oavsett stadium) skall vara högre än 80%. Frågor om MSI/MMR-analys besvaras för patienter som genomgått resektionskirurgi (alternativt endoskopisk polypektomi) eller genomgått neoadjuvant, adjuvant eller generaliserad behandling. Med sjukhus avses företrädesvis opererande sjukhus. Data redovisas bara till och med 2023 pga eftersläpning i registreringen.

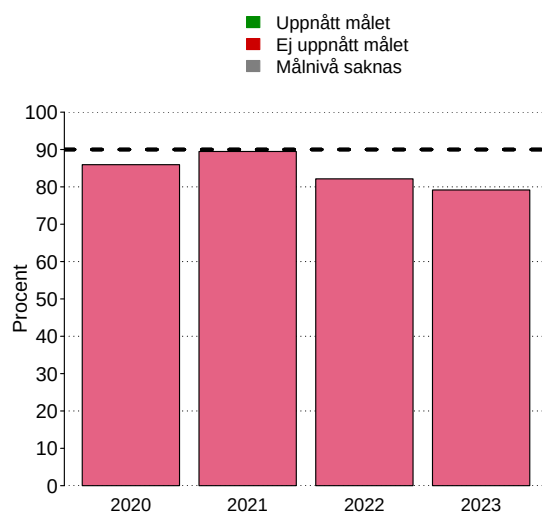


Figur 49. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 46. Tjocktarmscancer: Andelen som genomgått MSI/MMR-analys

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	60	73	4232	4296
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	75	87	404	443
Region				
Västernorrland	36	66	117	130
Jämtland	88	99	56	67
Västerbotten	92	96	131	146
Norrbotten	93	94	100	100
Sjukhus				
Lycksele		100	<5	6
NUS	92	95	78	73
Skellefteå	96	97	49	67
Sunderbyn	93	94	100	100
Sundsvall	34	76	64	79
Östersund	88	99	56	67
Övik	38	51	53	51

Tjocktarmscancer: Andelen adjuvant behandlade, stadium I-III inom 8 veckor från operation skall vara högre än 90%. Med sjukhus avses opererande sjukhus. Data redovisas bara till och med 2023 pga eftersläpning i registreringen av onkologisk behandling.

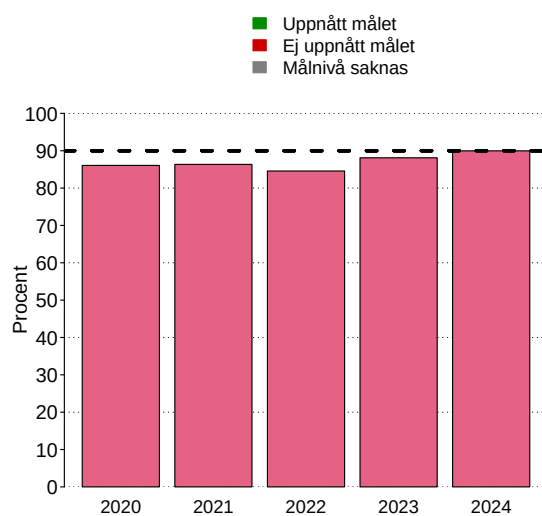


Figur 50. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 47. Tjocktarmscancer: Väntetid från operation till adjuvant behandling

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	87	84	743	642
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	82	79	56	96
Region				
Västernorrland	100	100	13	26
Jämtland	88	92	8	12
Västerbotten	78	88	18	33
Norrbotten	71	40	17	25
Sjukhus				
NUS	80	88	10	17
Skellefteå	75	88	8	16
Sunderbyn	71	40	17	25
Sundsvall	100	100	6	18
Östersund	88	92	8	12
Övik	100	100	7	8

Tjocktarmscancer: Andel tjocktarmscancerfall med väntetid från operation till PAD inom 21 dagar skall vara högre än 90% (cancerplanen 2022-2024). Med sjukhus avses opererande sjukhus.

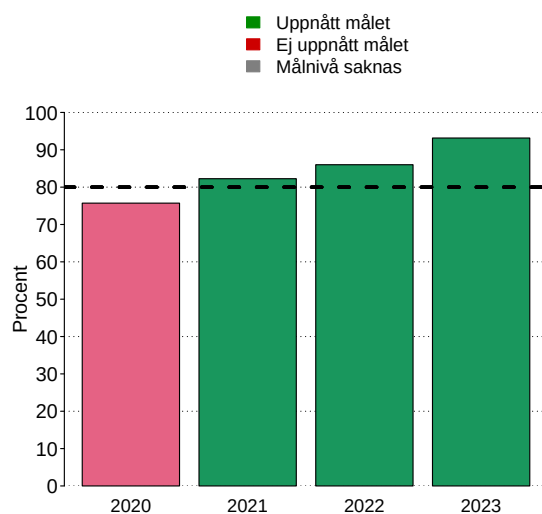


Figur 51. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 48. Tjocktarmscancer: Väntetid från operation till PAD

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	77	80	3726	2818
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	88	90	370	289
Region				
Västernorrland	97	98	103	90
Jämtland	91	72	55	40
Västerbotten	85	83	124	84
Norrbotten	80	97	88	75
Sjukhus				
Lycksele			<5	
NUS	80	83	60	64
Skellefteå	92	85	63	20
Sunderbyn	80	97	88	75
Sundsvall	100	100	60	47
Östersund	91	72	55	40
Övik	93	95	43	43

Tjocktarmscancer: Andelen patienter som fått palliativ cytostatikabehandling och som genomgått RAS/RAF-analys skall vara högre än 80%. Med sjukhus avses opererande sjukhus. Data redovisas uppdelat på när palliativ cytostatikabehandling startade till och med 2023 pga eftersläpning i registreringen av onkologisk behandling.



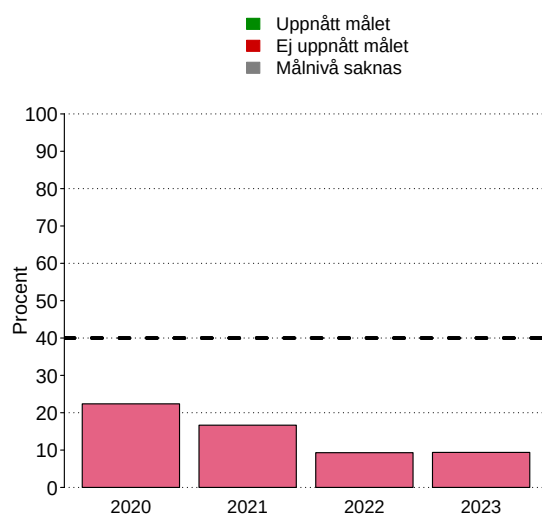
Figur 52. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 49. Tjocktarmscancer: Andelen som genomgått RAS/RAF-analys

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	86	86	456	526
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	86	93	50	73
Region				
Västernorrland	100	100	13	22
Jämtland	86	91	7	11
Västerbotten	94	100	18	24
Norrbotten	58	75	12	16
Sjukhus				
Lycksele		100		6
NUS	93	100	14	10
Skellefteå		100	<5	8
Sunderbyn	58	75	12	16
Sundsvall	100	100	7	8
Östersund	86	91	7	11
Övik	100	100	6	14

3.12 Ändtarmscancer

Ändtarmscancer: Andelen rektalcancrar som varit med i någon studie (klinisk eller onkologisk) skall vara högre än 40% enl cancerplanen 2022-2024. På sjukhusnivå redovisas resultat för opererande sjukhus. Data redovisas bara till och med 2023 pga eftersläpning i registreringen av onkologisk behandling.

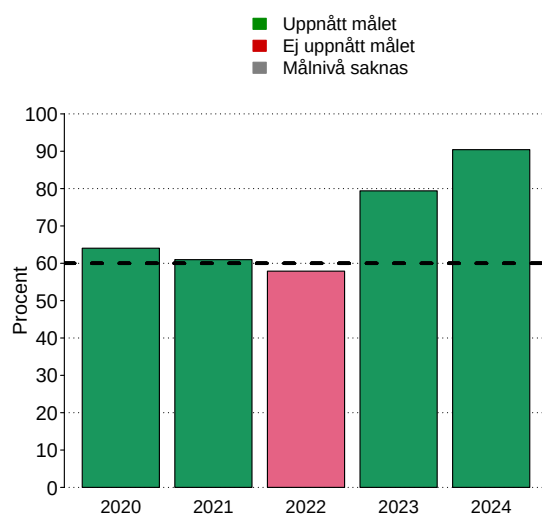


Figur 53. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 50. Ändtarmscancer: Inkluderad i studie

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	24	21	1653	1717
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	9	9	129	160
Region				
Västernorrland	24	6	34	31
Jämtland	0	0	14	16
Västerbotten	9	22	44	59
Norrbotten	0	0	37	54
Sjukhus				
NUS	10	23	42	57
Skellefteå			<5	<5
Sunderbyn	0	0	37	54
Sundsvall	24	6	34	31
Östersund	0	0	14	16

Ändtarmscancer: Andelen minimalinvasiv kirurgi (laparoskopiskt opererade) skall vara högre än 60%.
Med sjukhus avses opererande sjukhus

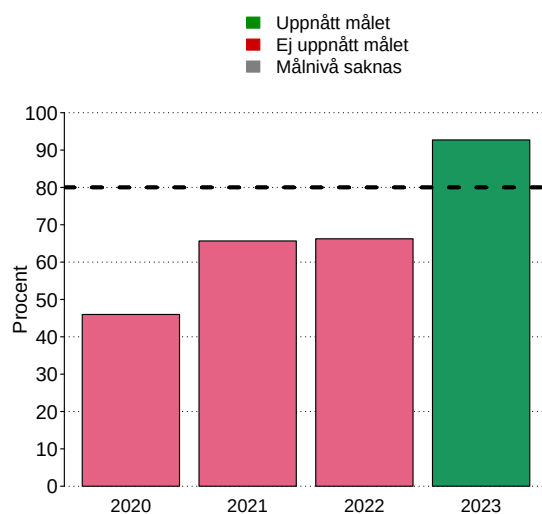


Figur 54. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 51. Ändtarmscancer: Minimalinvasiv kirurgi

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	85	88	1484	1197
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	79	90	131	94
Region				
Västernorrland	75	92	28	13
Jämtland	92	100	12	18
Västerbotten	73	86	52	35
Norrbotten	87	89	39	28
Sjukhus				
NUS	73	86	52	35
Sunderbyn	87	89	39	28
Sundsvall	75	92	28	13
Östersund	92	100	12	18

Ändtarmscancer: Andelen ändtarmscancerpatienter som genomgått MMR/MSI-analys någon gång (oavsett stadium) skall vara högre än 80%. Frågor om MSI/MMR-analys besvaras för patienter som genomgått resektionskirurgi (alternativt endoskopisk polypektomi) eller genomgått neoadjuvant, adjuvant eller generaliserad behandling. Med sjukhus avses företrädesvis opererande sjukhus. Data redovisas bara tom 2023 pga eftersläpning i registreringen

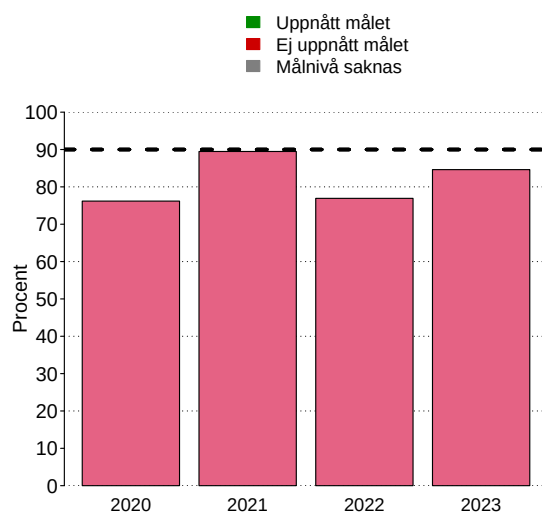


Figur 55. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 52. Ändtarmscancer: Andelen som genomgått MSI/MMR-analys

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	58	73	1836	1952
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	66	93	157	192
Region				
Västernorrland	45	78	40	41
Jämtland	58	96	19	25
Västerbotten	86	97	51	67
Norrbotten	66	97	47	59
Sjukhus				
Lycksele			<5	<5
NUS	87	97	46	63
Skellefteå			<5	<5
Sunderbyn	66	97	47	59
Sundsvall	42	79	38	38
Östersund	58	96	19	25
Övik			<5	<5

Ändtarmscancer: Andelen adjuvant behandlade, stadium I-III, inom 8 veckor skall vara högre än 90%. Med sjukhus avses opererande sjukhus. Data redovisas bara till och med 2023 pga eftersläpning i registreringen av onkologisk behandling.

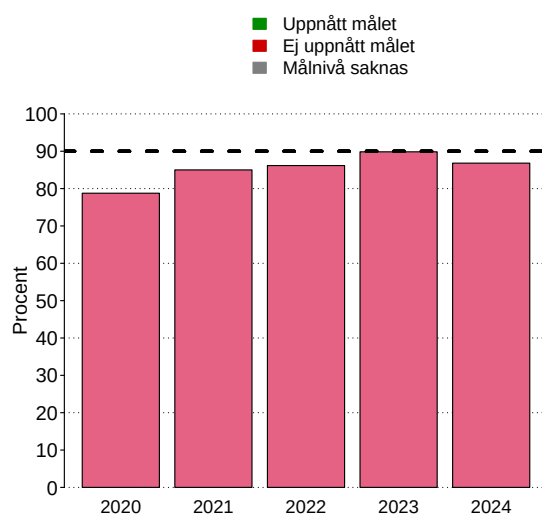


Figur 56. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 53. Ändtarmscancer: Väntetid från operation till adjuvant behandling

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	87	89	175	129
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	77	85	13	13
Region				
Västernorrland			<5	<5
Jämtland			<5	<5
Västerbotten	100		5	<5
Norrbotten			<5	<5
Sjukhus				
NUS	100		5	<5
Sunderbyn			<5	<5
Sundsvall			<5	<5
Östersund			<5	<5

Ändtarmscancer: Andelen ändtarmscancerfall med väntetid från operation till PAD skall vara inom 21 dagar för 90% av patienterna. Med sjukhus avses opererande sjukhus.

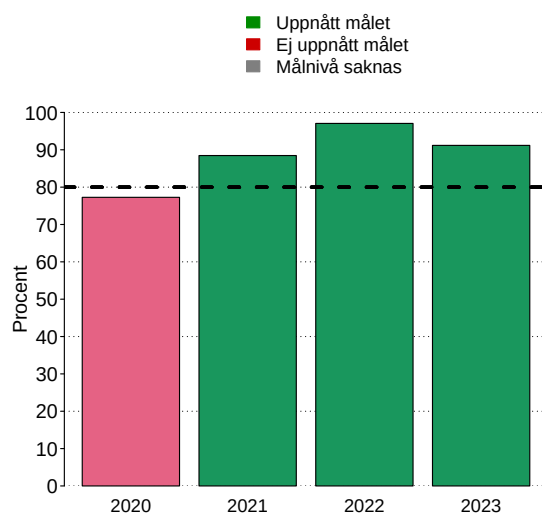


Figur 57. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 54. Ändtarmscancer: Väntetid från operation till PAD

	Procent		Antal diagnoser	
	2023	2024	2023	2024
Riket				
Riket	77	79	1366	950
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	90	87	128	91
Region				
Västernorrland	96	100	28	13
Jämtland	83	82	12	17
Västerbotten	84	79	51	34
Norrbotten	95	93	37	27
Sjukhus				
NUS	84	79	51	34
Sunderbyn	95	93	37	27
Sundsvall	96	100	28	13
Östersund	83	82	12	17

Ändtarmscancer: Andelen patienter som fått palliativ cytostatikabehandling och som genomgått RAS/RAF-analys skall vara högre än 80%. Med sjukhus avses opererande sjukhus. Data redovisas uppdelat på när palliativ cytostatikabehandling startade till och med 2023 pga eftersläpning i registreringen av onkologisk behandling.



Figur 58. Norra sjukvårdsregionen

Tabell 55. Ändtarmscancer: Andelen som genomgått RAS/RAF-analys

	Procent		Antal diagnoser	
	2022	2023	2022	2023
Riket				
Riket	85	82	205	207
Sjukvårdsregion				
Norra regionen	97	91	34	34
Region				
Västernorrland	86	100	7	9
Jämtland		82	<5	11
Västerbotten	100	88	14	8
Norrbotten	100	100	9	6
Sjukhus				
Lycksele				<5
NUS	100	80	13	5
Skellefteå			<5	<5
Sunderbyn	100	100	9	6
Sundsvall	83	100	6	6
Östersund		82	<5	11
Övik			<5	<5